111年度勞工健康服務模式分享會
健康風險評估、特作分級與管理

1.職場健康危害辨識及執行方式

2.職場健康風險管理 監測及評估

桃園敏盛綜合醫院 環境職業醫學科
(竹科員工診所) 楊慎絢 醫師

2022.9.15 10:40—12:10

健康風險評估、特作健檢分級 與健康管理

	職場健康危害辨識 及執行方式
1	**特別**危害健康作業【健康管理計畫/(32種)健檢表格】
2	特殊作業健檢異常分級 與職業暴露之相關性
3	32種勞工**特殊**體格(**健**康)**檢**查實務
4	特別危害健康作業健檢【健康管理】分級
	職場健康風險管理 監測及評估
5	A.【全國勞工健康檢查資料庫登錄平台】
6	B.【勞工健康保護管理報備資訊系統】
7	特殊健康檢查【健康管理】第一, 二級管理
8	特殊健康檢查【健康管理】第三級管理
9	特殊健康檢查【健康管理】第四級管理
10	建議不適宜從事__作業/ 建議調整工作】

特別危害健康作業健康管理計畫

一、前言：依據「職業安全衛生法」第 21、22 條與「勞工健康保護規則」第 16～21 條，「勞工職業災害保險預防職業病健康檢查及健康追蹤檢查辦法」，擬訂特別危害健康作業(特殊作業)健康管理計畫。第 4 條 附表2

二、目的：辨識與評估特殊作業的危害因子，採取預防措施；辦理作業員工之健康檢查與健康管理，保護員工健康。

三、組織與任務：參考「特殊作業健康管理流程圖」(附錄一)，依職責推動。

1.雇主：(1).指定執行者與協調者，例如：廠護、職安、人資或部門主管，規劃可調整的職務與工作場所。(2).參考醫療建議，採取選工配工的調整措施，例如：縮短工作時間、更換工作內容、變更作業場所等。

2.醫療人員：(1).規劃特殊健檢與一般健檢，分析報告(附錄二)與健康管理分級(附錄三)。(2).健康諮詢與衛教指導(附錄四)。(3).選工與配工的工作適性評估(附錄五)。(4).健康管理分級通報與後續追蹤。(5).建立健康管理之績效指標(附錄六)。

四、本計畫執行紀錄或文件等應歸檔留存三年以上。

管理計畫

1. 流程圖
2. 健檢表格
3. 管理分級
4. 健康指導
5. 工作評估
6. 績效指標

ys591@ms2.hinet.net

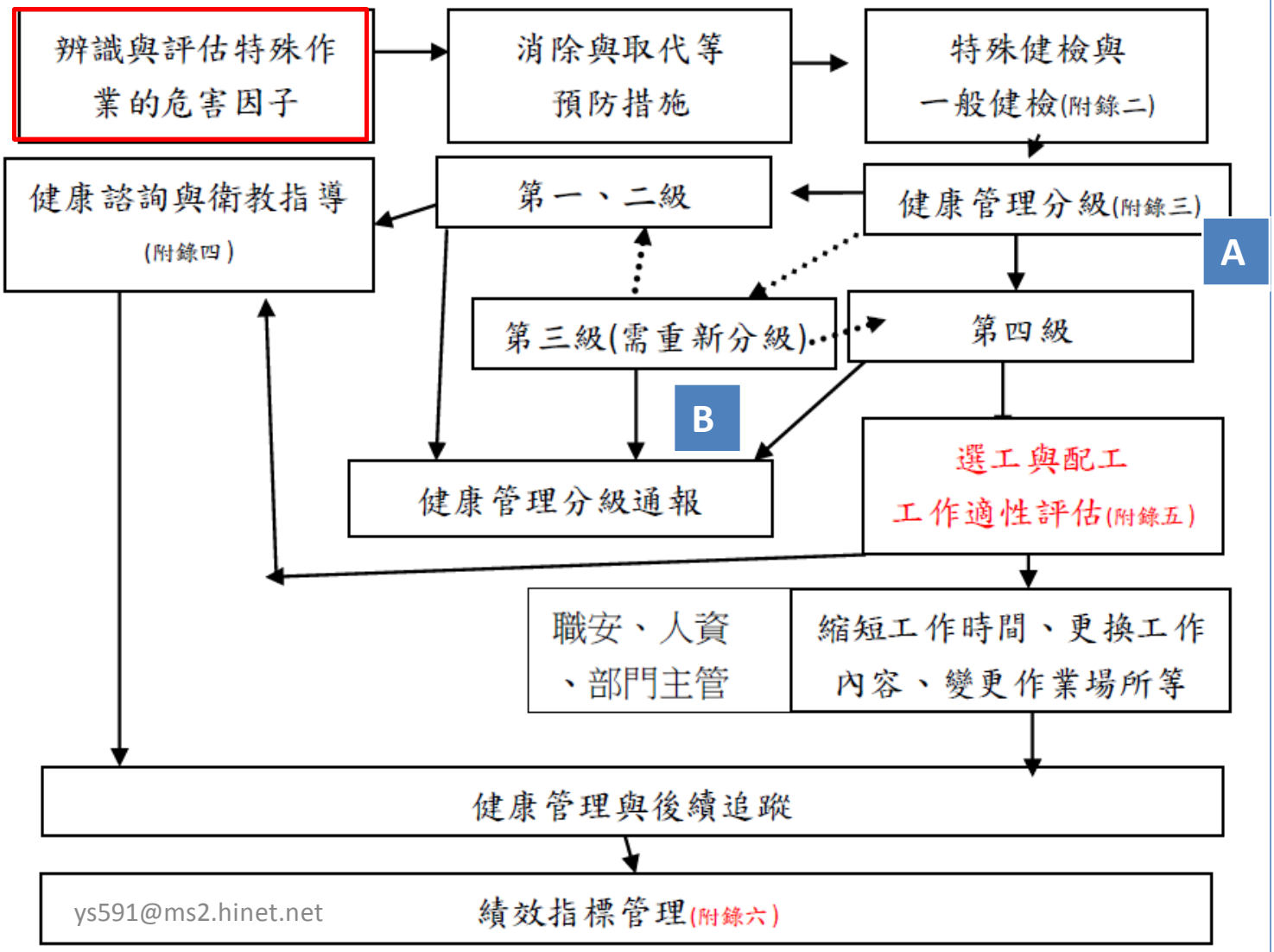
【附錄一】特殊作業健康管理流程圖

依據特殊健檢健康管理分級，提供健康指導與工作適性評估。流程圖為建議模式，非唯一模式，在經過試行後，再進行修訂，以符合現狀。

管理計畫
1.流程圖
2.健檢表格
3.管理分級
4.健康指導
5.工作評估
6.績效指標

網路通報

A	健檢醫院
B	職場



ys591@ms2.hinet.net

(編號1-32) 特殊健檢

十、健康管理
□第一級管理
□第二級管理
□第三級管理（應註明臨床診斷）_____
□第四級管理（應註明臨床診斷）_____

三、檢查時期（原因）：□新進員工（受僱時） □變更作業
□定期檢查 □健康追蹤檢查

十一、應處理及注意事項（可複選）
1. □檢查結果大致正常，請定期健康檢查。
2. □檢查結果異常，宜在（期　　限）內至醫療機構_____科，實施健康追蹤檢查。
3. □檢查結果異常，建議不適宜從事_____作業（請說明原因：　　）。
4. □檢查結果異常，應在（期　　限）內至聘有職業醫學科專科醫師之門診實施健康追蹤檢查。
5. □檢查結果異常，建議調整工作（可複選）：
   □縮短工作時間（請說明原因：　　）。
   □更換工作內容（請說明原因：　　）。
   □變更作業場所（請說明原因：　　）。
   □其他：_____（請說明原因：　　）。
6. □其他：_____。

健檢機構名稱、電話、地址：
健檢醫師姓名(簽章)及證書字號：
健康管理分級醫師姓名(簽章)及證書字號：

管理計畫

1.流程圖
2.健檢表格
3.管理分級
4.健康指導
5.工作評估
6.績效指標

ys591@ms2.hinet.net

資料來源：職安署「職業傷病服務管理中心」
https://tmsc.osha.gov.tw/info_03.asp?Page=2&sl&fbclid=IwAR06dh3CbV-e9dfHHv0l-rmN5RzXQ8bFOvT3wI2QVvbf6-P6_DQtxRS7dcg

圖 1 鉛作業健康指導衛教單



圖 2 鎳作業健康指導衛教單



圖 3 鈾作業健康指導衛教單



圖 4 砷作業健康指導衛教單



ys591@ms2.hinet.net

附錄五

管理計畫

1.流程圖

2.健檢表格

3.管理分級

4.健康指導

5.工作評估

6.績效指標

2022/9/2

工作適性評估表

部門	單位	職稱	姓名	工號	性別	年齡

健康問題：☐一般疾病 ☐職場復工、配工、選工 ☐健檢健康管理

☐工作異常負荷 ☐骨骼肌肉傷害 ☐母性健康管理 ☐其它：

健康狀況簡述：

面談參與人員	
工作內容概要	
醫師面談概要 (含與部門主管協議內容)	

指導區分

醫療或健康指導

☐1. 需要接受治療 ☐2. 須要追蹤觀察 ☐3. 須要接受飲食及生活習慣等衛教指導

☐4. 不須要接受治療

工作調整指導

☐1. 可繼續從事目前的工作

☐2. 可繼續從事工作，但須考量下列條件限制:

☐1).變更工作場所：

☐2).變更職務：

☐3).縮減職務量：

☐縮減工作時間： ☐縮減業務量：

☐4).限制加班（不得超過 小時／天）

☐5).周末或假日之工作限制（每月 次）

☐6).出差之限制（每月 次）

☐7).夜班工作之限制（輪班工作者）(每月 次）

☐3. 不可繼續工作，宜休養(休養期間：敘明時間)

☐4. 其它具體之工作調整或生活建議(包括工作調整或異動、追蹤或職場對應方法、飲食等詳細之建議內容)

ys591@ms2.hinet.net

附錄六

管理計畫

1.流程圖

2.健檢表格

3.管理分級

4.健康指導

5.工作評估

6.績效指標

【附錄六】 特殊作業健康管理之績效指標

執行項目	執行結果（人次或%）	備註（改善情形）
健康檢查項目分級管理結果	第一級管理人數_____人(_____%) 第二級管理人數_____人(_____%) 第三級管理人數_____人(_____%) 第四級管理人數_____人(_____%) (依特殊健檢類別分別列出) (可另列明重新分級的管理人數及百分比)	
辨識及評估健康檢查異常者	第三級者重新分級為第二級者_____人 第三級者重新分級為第四級者_____人 (健檢報告異常且可能有考量不適合疾病者___人)	
安排護理師面談及健康指導	1.需護理師面談者_____人 1.1 需觀察或進一步追蹤檢查者___ 人 1.2 需進行醫療者 ___人 2.需健康指導者___人 2.1 已接受健康指導者 ___人	
安排醫師面談及健康指導	1.需醫師面談者___人 1.1 需觀察或進一步追蹤檢查者___人 1.2 需進行醫療者 ____人 2.需健康指導者___人 2.1 已接受健康指導者_人	
調整或縮短工作	1.經評估，需適性配工者___人	

ys591@ms2.hinet.net

	2.經安排，實際完成適性配工者___人 2.1 實際調整或縮短工作時間 _人 2.2 實際變更工作者___人 2.3. 實際調整工作內容者____人	
實施健康檢查、管理及促進	1.應實施健康檢查者___人 1.1 實際受檢者___人 1.2 檢查結果異常者___人 1.3 需複檢者____人	
	2.應定期追蹤管理者___人 3.參加健康促進活動者 ____人	
執行成效之評估及改善	1.參與健康檢查率___% 2.健康促進達成率 ____% 3.與上一次健康檢查異常結果項目比較，異檢率___% （上升或下降） 4.環境改善情形： (環測結果）	
其他事項	**(健康追蹤檢查**: 類別 人數)	

註：本表執行結果為例舉，事業單位得依需求修正與增列。

可將上述結果，定期檢討、改善及持續修正，並於職業安全衛生委員會報告，做為下一年度規劃勞工健康服務業務的參考。

管理計畫

1.流程圖

2.健檢表格

3.管理分級

4.健康指導

5.工作評估

6.績效指標

ys591@ms2.hinet.net

第 4 條 附表2

預防職業病
健康追蹤檢查

作業: 附表二

1	變更作業
2	離職
3	退保後

醫療健檢機構通知
受檢人及**保險人**

附表二　預防職業病健康追蹤檢查之作業類別

項次	作業名稱
一	游離輻射防護法所稱之游離輻射作業。
二	粉塵危害預防標準所稱之粉塵作業。
三	有機溶劑中毒預防規則所稱之下列有機溶劑作業： (一)三氯乙烯。 (二)四氯乙烯。
四	製造、處置或使用下列特定化學物質或其重量比（苯為體積比）超過百分之一之混合物之作業： (一)聯苯胺及其鹽類。 (二)4-胺基聯苯及其鹽類。 (三)4-硝基聯苯及其鹽類。 (四)β-萘胺及其鹽類。 (五)二氯聯苯胺及其鹽類。 (六)α-萘胺及其鹽類。 (七)鈹及其化合物（鈹合金時，以鈹之重量比超過百分之三者為限）。 (八)氯乙烯。 (九)苯。 (十)石綿（以處置或使用作業為限）。 (十一)鉻酸與其鹽類或重鉻酸及其鹽類。 (十二)砷及其化合物。 (十三)鎘及其化合物。 (十四)鎳及其化合物。 (十五)甲醛。 (十六)1,3-丁二烯。 (十七)銦及其化合物。
五	聯吡啶或巴拉刈之製造作業。
六	其他經中央主管機關指定公告之作業。

勞工職業災害保險預防職業病健康檢查及健康追蹤檢查辦法 第 4 條 2022.3.14

ys591@ms2.hinet.net

一般+32種勞工特殊體格(健康)檢查之記錄格式(2022.6.2公告)

一般及特殊體格(健康)檢查記錄格式

https://www.osha.gov.tw/1106/29647/1141/13440/

顯示條件查詢

標題	最後異動日期
勞工一般體格及健康檢查紀錄格式	111-06-02
配合111年6月2日公告32種勞工特殊體格(健康)檢查之	111-06-08
編號1 高溫作業 勞工特殊體格及健康檢查紀錄	111-06-02
編號2 噪音作業勞工特殊體格及健康檢查紀錄	111-06-08
編號3 游離輻射作業勞工特殊體格及健康檢查紀錄	111-06-02
編號4 異常氣壓作業勞工特殊體格及健康檢查紀錄	111-06-02
編號5 鉛作業勞工特殊體格及健康檢查紀錄	111-06-02
編號6 四烷基鉛作業勞工特殊體格及健康檢查紀錄	111-06-02

編號	作業	檢查項目(舉例)
1	高溫	心電圖/**肺功能***
2	噪音	純音聽力圖
3	游離輻射	甲狀腺/血液/*
5,6	鉛/四烷基鉛	血鉛/尿鉛
19	砷	尿砷
23	粉塵	胸部X光 /*
26	**鎳**	尿鎳 /*
27	乙基汞..	血汞
31	**鋦**	血鋦 /*
32	汞及無機..	尿汞

32種勞工特殊體格(健康)檢查之記錄格式 (配合2022.6.2公告)

特殊體格(健康)檢查記錄格式填寫說明及注意事項

一、事業單位或勞工填寫資料之注意事項如下： https://www.osha.gov.tw/1106/29647/1141/13440/

請事業單位於勞工受檢前，就其填妥個人基本資料、作業經歷、檢查時期、既往病史、生活習慣、自覺症狀及作業環境監測資料，其中基本資料之事業單位名稱、地址及作業環境監測資料，並請事業單位協助填寫；若以上資料事業單位已提供電子檔給醫療機構，可不必請受檢勞工重複填寫，相關填寫注意事項重點如下：

（一）基本資料：事業單位名稱請填寫全銜，若有多廠者，需加註廠別及地址。

（二）作業經歷：目前從事內容，請填寫職稱及具體從事作業之內容。

（三）既往病史：請勞工勾選過去或現在所罹患疾病，若有未明列之疾病，請勞工填寫於其他之空白欄位。

（四）自覺症狀：請勞工勾選近三個月實際感受身體不適之症狀，若有未明列之症狀，請勞工填寫於其他之空白欄位。

（五）作業環境監測資料：事業單位依勞工作業環境監測實施辦法或游離輻射防護法應實施作業環境或個人劑量監測者，方需填寫作業環境監測資料，請依實際狀況確實填寫，及載明勞動部職業安全衛生署「勞工作業環境監測及暴露危害管理網路登錄系統」之事業單位編號，共計12碼數字，並應依勞工健康保護規則規定，將最近一次之作業環境監測紀錄提供予檢查之醫療機構，俾利醫師瞭解暴露情形及評估健康管理分級。

勞工作業場所容許暴露標準

危害辨識

特別危害健康作業	ppm	mg/m3
四氯化碳	2	13
三氯乙烯	50	269
四氯乙烯	50	339
二甲基甲醯胺	10	30
氯乙烯	1	2.6
苯	1	3.2
二異氰酸甲苯	0.005	0.036
砷及其化合物		0.01
汞及其無機化合物		0.05
汞有機化合物		0.01

空氣中粉塵容許濃度 mg/m3

	(含結晶型游離)	可呼吸性粉塵	總粉塵
第一種粉塵	SiO2>10%	10	30
第二種粉塵	SiO2<10%	1	4
第三種粉塵	石綿纖維	0.15 f/cc	
第四種粉塵	厭惡性粉塵	5	10

勞工作業場所容許暴露標準

特別危害健康作業	ppm	mg/m3
鎳及非溶性化合物		0.1
鉛及其無機化合物		0.05
四氯乙烷	1	6.9
二硫化碳	10	31
鈹及其化合物		0.002
錳燻煙		1
錳及其無機化合物		5
黃磷		0.1
六價鉻化合物		0.05
二價鉻化合物		0.5
三價鉻化合物		0.5
鎘及其化合物		0.05
1-溴丙烷	0.5	2.6
1,3-丁二烯	5	11
甲醛	1	1.2
銦及其化合物		0.1

(編號1) 高溫作業健檢

四、既往病史　您是否曾患有下列慢性疾病：(

1. 心臟血管：□高血壓　□缺血性心臟病　□心絞痛　□心肌梗塞　□無
2. 呼吸系統：□氣喘　□無
3. 內　分　泌：□糖尿病　□甲狀腺功能亢進　□無
4. 腎臟泌尿：□腎功能異常　□腎結石　□無
5. 生殖系統：□不孕　□無
6. 皮膚系統：□皮膚紅疹　□大面積燒燙傷　□無汗症　□無
7. 免疫性疾病：□嚴重的細菌性或病毒性感染症　□_____　□無
8. 長期服用藥物：□利尿劑　□降血壓藥物　□鎮定劑　□抗癲癇劑
   □抗血液凝固劑　□抗膽鹼激素劑　□抗精神病藥
   □甲狀腺素　□減肥藥　□興奮劑　□其他_____　□無
9. 熱傷害：□熱痙攣　□熱暈厥　□熱衰竭　□中暑　□橫紋肌溶解　□無
10. 其　他□_____　□無

3. 心電圖：_____

4. 肺功能檢查（包括用力肺活量(FVC)、一秒最大呼氣量($FEV_{1.0}$)及 $FEV_{1.0}$ /FVC)：

5. 生化血液檢查：飯前血糖(sugar AC)_____　血中尿素氮(BUN)_____
   肌酸酐(creatinine)_____　鈉_____　鉀_____　氯_____

6. 血液檢查：血色素_____

7. 尿液檢查：尿蛋白____　尿潛血____

1.各職場應依據作業特性與健檢機構提供的參考值，另訂健康管理方式。
2.為區別特殊健檢的第一二三四級，將一般勞工健檢分為 ABCD 級管理。

項目	第 A 級	第 B 級	第 C 級	第 D 級
身體質量指數 (BMI,kg/m²)	18.5-24.9	≤18.4 25.0-29.9	30.0-34.9	≥35.0
腰圍(cm)	男性<90 女性<80	男性≥90 女性≥80		
收縮壓(mmHg)	<130	130-139	140-159	≥160
舒張壓(mmHg)	<85	85-89	90-99	≥100
心跳	60-99	45-59 100-110	40-44 110-120	≤39 ≥120 合併頭暈、喘等症狀
胸部 X 光	正常	陳舊性肺結核，肺紋增加，肺部小鈣化點，肺尖肋膜增厚	肺部結節<1 公分，肺纖維化病灶，肺部輕微浸潤	肺部中度至嚴重浸潤，疑似肺結核，肺結節>1 公分，肺部陰影，肺部腫瘤，肋膜積水，氣胸
蛋白尿	陰性	邊緣值	+~++	+++~++++
尿潛血	陰性	邊緣值	+~++	+++~++++
血色素 (g/dL) (若為已知的地中海貧血患者，不在此限)	男性 13.0-18.0 女性 12.0-16.0	男性 11.0-12.9 女性 9.0-11.9	男性 9.0-10.9 女性 7.0-8.9	男性 <9.0, >18.0 女性 <7.0, >16.0
白血球 (/μL)	3000 - 9000	9100-12000 2001-2999	12000-14999 1501-2000	≥15000 ≤1500
空腹血糖 (mg/dL)	<100	100-125	126-199 且有已知糖尿病史、正在服用降血糖藥物	≥126 且從過去無糖尿病史者 ≥200 無論有無糖尿病史

附錄二

(編號1) 高溫作業健檢

	心電圖檢查
優先健康評估	心房顫動，心室期外收縮
	心房顫動
	心室期外收縮，心肌缺氧
	竇性心律快速，心肌缺氧
	陳舊性側壁、前壁、後壁、下壁梗塞，心肌缺氧
	心肌缺氧，竇性心律緩慢
	心肌缺氧
	第二度、第三度心房室傳導阻斷
	完全性左側支束傳導阻斷，
	竇性心律不整
	心室期外收縮
健康評估	左前支束傳導阻斷，竇性心律緩慢
	不完全性右側支束傳導阻斷，竇性心律緩慢
	第一度心房室傳導阻斷
	右側支束傳導阻斷,左心房擴大，
	第一度心房室傳導阻斷,左心房擴大，
	左前支束傳導阻斷
健康指導	竇性心律緩慢
	竇性心律快速
	不特定性 ST-T 波變化
	左心房擴大

(編號1) 高溫作業健檢

2022.3.16

高溫作業分級	人數	同仁	診斷	
四	5		伍爾夫帕金氏懷特症候群	1.三個月內，至心臟內科門診追蹤。 2. 建議一個月內安排工作適性評估。
			心房顫動併異常傳導	
			高血壓	
			高血壓、糖尿病	
			心房顫動，快速心室反應併 S-T 節變化	

2022.4.18

高溫作業分級	人數	同仁	診斷	應處理及注意事項
四	5		伍爾夫帕金氏懷特症候群	1.因疫情嚴峻，已安排兩個月內至心臟內科門診追蹤。 2.今日追蹤五人均已定期量測血壓與紀錄(　　先生已自行服藥治療)(　　小姐已裝心臟血管支架)。門診追蹤診治，若有不適，另約工作評估。
			心房顫動併異常傳導	
			高血壓	
			高血壓、糖尿病	
			心房顫動，快速心室反應併 S-T 節變化	

2022.5.23

四、建議採行措施：(針對發現問題所採行之措施)

(1).以上同仁，若有不適，門診追蹤，另約工作複評。以及定期健檢追蹤。

五、對於前次建議改善事項之追蹤辦理情形：

ys591@ms2.hinet.net

(1).年度特殊作業健檢，高溫作業健康管理第四級 5 人，今日追蹤已調至較低溫區與通風處，並於門診追蹤診治　　先生已自行服藥治療)(　　小姐已裝心臟血管支架)。

十、健康管理	十一、應處理及注意事項（可複選）								
□第一級管理 □第二級管理 □第三級管理（應註明臨床診斷） □第四級管	0	1	2	3	4a	4b	4c	4d	9
	1.□檢查結果大致正常，請定期健康檢查。	2.□檢查結果異常，宜在（期限）內至醫療機構__科，實	3.□檢查結果異常，建議不適宜從事_____作業（請說	4.□檢查結果異常，應在（期限）內至聘有職業醫學科專	5.□檢查結果異常，建議調整工作（可複選）：				6.□其他：
					□縮短工作時間（請說明原因：	□更換工作內容（請說明原因：	□變更作業場所（請說明原因：	□其他：_____（請說明原因：	

十一、應處理及注意事項（可複選）
1.□檢查結果大致正常，請定期健康檢查。填0
2.□檢查結果異常，宜在（期　限）內至醫療機構____科，實施健康追蹤檢查。填1
3.□檢查結果異常，建議不適宜從事_____作業（請說明原因：___）。填2
4.□檢查結果異常，應在（期　限）內至聘有職業醫學科專科醫師之門診實施健康追蹤檢查。填3
5.檢查結果異常，建議調整工作（可複選）：
□縮短工作時間（請說明原因：____）。填4a
□更換工作內容（請說明原因：____）。填4b
□變更作業場所（請說明原因：____）。填4c
□其他：_____（請說明原因：____）。填4d
6.□其他：_____。填9

只須要填寫空格內容即可，如（期　限）、___科、_____作業、請說明原因：_____。
如非1-5的說明，請選擇6，其他：_____，敘明應處理及注意事項

勞工健康保護規則 第十三條
第二級管理以上者，應由醫師註明其不適宜從事之作業與其他應處理及注意事項；
屬於第三級管理或第四級管理者，並應由醫師註明臨床診斷。

為利於後續勾稽之用，期限，僅限填天數，如90天、180日等，而非日期，如105年4月30日

ys591@ms2.hinet.net

編號2　噪音作業 勞工特殊體格及健康檢查

(編號2) 噪音作業健檢

一、基本資料

1. 姓名：_____ 2. 性別：□男 □女 3. 身分證字號(護照號碼)：

4. 出生日期__年__月__日　5. 受僱日期__年__月__日　6. 檢查日期__年__月__日

7. 事業單位名稱(廠別)_____地址_____

二、作業經歷

1. 曾經從事_____，起始日期：__年__月，截止日期：__年__月，共__年__月

2. 目前從事_____，起始日期：__年__月，截至__年__月，共__年__月

3. (1)平均每週工作日數□6 □5.5 □5 □4.5 □4 □其他___日

(2)平均每日工作總時數□12 □10 □8 □6 □4 □其他___小時

(3)平均每日從事噪音作業時數約□12 □10 □8 □6 □4 □其他__小時

4.您於本次聽力檢查前14小時內曾於噪音環境嗎？□有 □無

5.1你曾從事過以下工作嗎？

□紡織 □開礦 □造船 □重工業 □築路 □砲兵、射擊隊、航空地勤

□必須大聲呼叫才能超過噪音量的其他工作 □以上皆無

5.2如果從事上面的任何工作：

(1)現場環境有聽力保護設備嗎？ □有 □無

(2)個人有戴上聽力防護用具嗎？ □有 □無

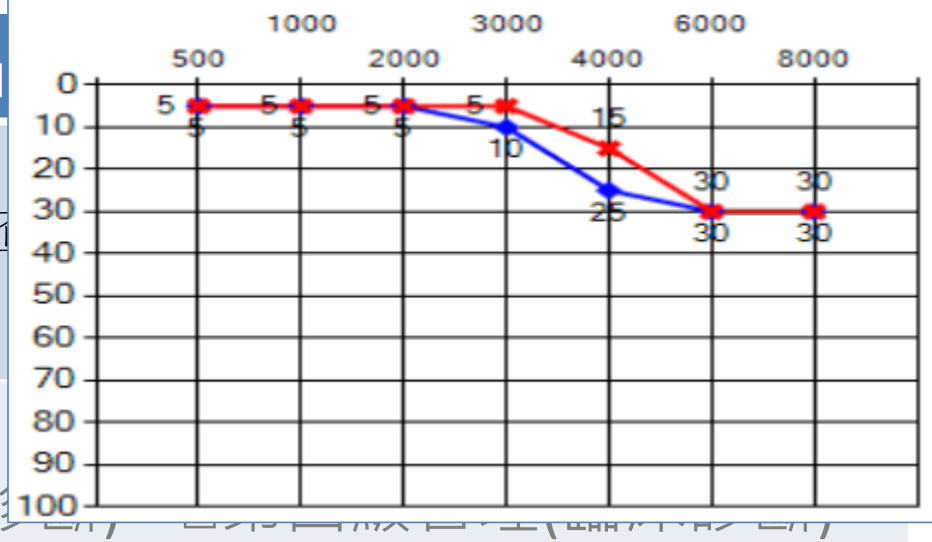
(3)若有，為何種類型？(多選題) □耳罩 □耳塞 □其他

(4)工作佩戴時間？□全時間佩戴 □一半時間佩戴 □都不戴

ys591@ms2.hinet.net

A先生41歲「噪音作業健檢」

1. 法定健康檢查項目有異常發現，
經醫師認定需於下年度相同特殊健康檢查
類別實施前接受健康追蹤檢查。



十、健康管理: □第一級管理
■第二級管理 □第三級管理(臨床診斷)

十一、「應處理及注意事項」(可複選)

1.檢查結果大致正常，請定期健康檢查。

■ 2.檢查結果部分異常，請參照醫師評語，實施健康追蹤檢查。

3.檢查結果異常，建議不適宜從事____作業(原因　　)。

4.檢查結果異常，應在___內至聘有職業醫學科專科醫師之門診實施健康追蹤檢查。

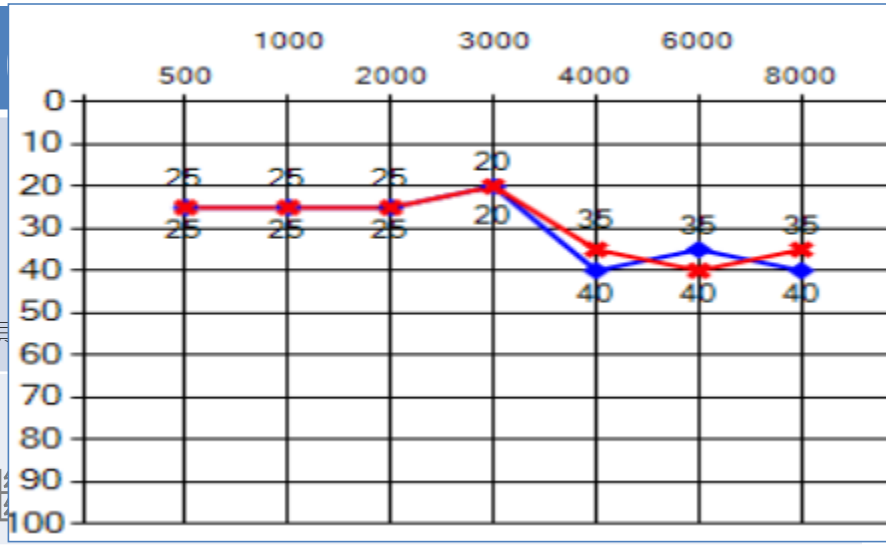
5.檢查結果異常，建議調整工作(可複選)：
□縮短工作時間□更換工作內容□變更作業場所(原因　)□其他：

■ 6.其他:定期量測血壓,健檢追蹤,事業單位須進行聽力防護計畫

一般及特殊體格(健康)檢查記錄格式 https://www.osha.gov.tw/1106/29647/1141/13440/

B先生58歲「噪音作業健檢」

1. 法定健康檢查項目有異常發現，經醫師認定需於下年度相同特殊健康檢查類別實施前接受健康追蹤檢查；如聽力檢查依三分法〔(0.5K+1K+2K)/3〕平均聽力損失≥ 25分貝



十、健康管理: □第一級管理

■第二級管理 □第三級管理(臨床診

十一、「應處理及注意事項」(可複選)

1.檢查結果大致正常，請定期健康檢查。

■ 2.檢查結果部分異常，請參照醫師評語，實施健康追蹤檢查。

3.檢查結果異常，建議不適宜從事____作業(原因　　)。

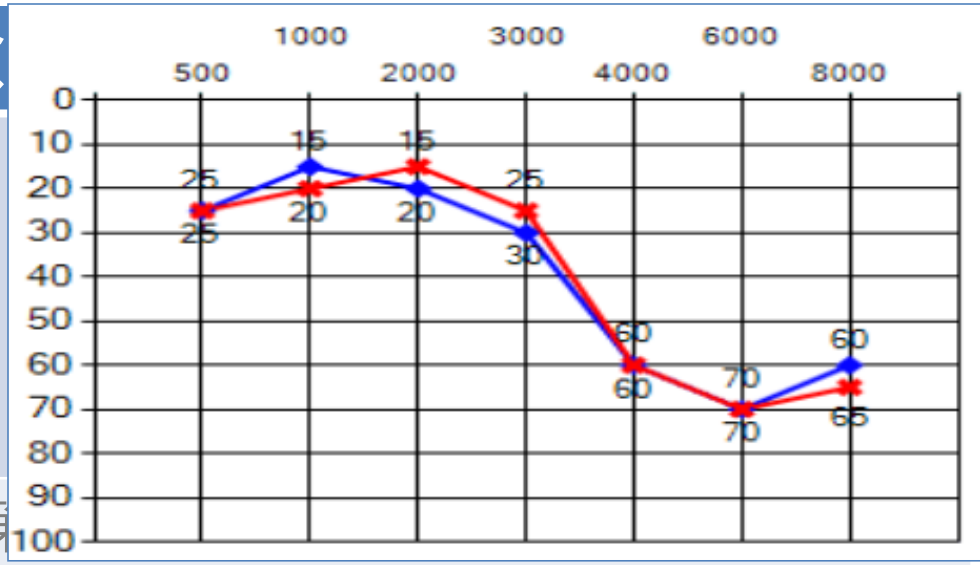
4.檢查結果異常，應在___內至聘有職業醫學科專科醫師之門診實施健康追蹤檢查。

5.檢查結果異常，建議調整工作(可複選)：
□縮短工作時間□更換工作內容□變更作業場所(原因　)□其他：

■ 6.其他:定期健檢追蹤,事業單位須進行聽力防護計畫。並請勞工健康服務醫師追蹤評估。

一般及特殊體格(健康)檢查記錄格式 https://www.osha.gov.tw/1106/29647/1141/13440/

C先生41歲「噪音作業健檢



2. 聽力防護計畫或噪音作業限制：
2.1 聽力檢查結果三分法〔(0.5K+1K+2K)/3
平均聽力損失小於25分貝，且出現4或6 K
凹陷(聽力損失大於40分貝以上)，
加註”為早期噪音性聽力損失，
事業單位須進行聽力防護計畫”。

十、健康管理: □第一級管理 □第

■第四級管理(**早期噪音性聽力損失**)

十一、「應處理及注意事項」(可複選)

1.檢查結果大致正常，請定期健康檢查。

■ 2.檢查結果部分異常，請參照醫師評語，實施健康追蹤檢查

3.檢查結果異常，建議不適宜從事____作業(原因　　)。

4.檢查結果異常，應在___內至聘有職醫科醫師之門診實施健康追蹤檢查。

5.檢查結果異常，建議調整工作(可複選)：
□縮短工作時間□更換工作內容□變更作業場所(原因) □其他：

■ 6.其他:定期健檢追蹤。事業單位須進行聽力防護計畫，並請勞工健康服務醫師追蹤評估。

一般及特殊體格(健康)檢查記錄格式 https://www.osha.gov.tw/1106/29647/1141/13440/

D先生60歲「噪音作業健檢」(如圖)

2.2 聽力檢查結果三分法〔(0.5K+1K+2K)/3〕平均聽力損失**大於或等於25分貝**，且出現4 K或6 K凹陷。高音頻平均聽力〔(3K+4K+6K)/3〕損失大於低音頻平均聽力〔(0.5K+1K+2K)/3〕損失10分貝以上。加註”為**噪音性聽力損失，事業單位須進行聽力防護及配工計畫**”。

2.3 三分法〔(0.5K+1K+2K)/3〕平均聽力損失與前一年度檢查結果比較變化少於10分貝，可每年實施健康檢查或追蹤檢查加註”**事業單位須進行聽力防護計畫**”。

左耳/右耳			左耳						右耳					
頻率(Hz)			500	1k	2k	3k	4k	6k	500	1k	2k	3k	4k	6k
基準聽力閾值 (民國 103 年)			35	35	25	35	35	30	25	35	30	35	55	55
入廠 7 年聽力閾值 (民國 110 年)			35	50	65	70	70	65	40	45	70	70	80	75
入廠後聽力閾值變化值=(2)-(1)			0	15	40	35	35	35	15	10	40	35	25	20
53	歲	男	性聽力閾值常模值(基準年份	14	16	15	18	19	22	14	16	15	18	19	22
60	歲	男	性聽力閾值常模值(比較年份	17	19	19	23	25	30	17	19	19	23	25	30
年齡導致之聽力衰減值=(5)-(4)				3	3	4	5	6	8	3	3	4	5	6	8
職業暴露導致之聽力衰減值=(3)-(6)				-3	12	36	30	29	27	12	7	36	30	19	12
評估2k、3k、4k之變化值是否超過10dB						31.66666667						28.33333333		
三分法平均聽力值 增加(>10 dB)				18.33333333						21.66666667				
3K 聽力值增加(>20 dB)						35						35		
(4K+6K)/2平均聽力值增加(>30dB)							35						22.5	

十、健康管理:□第一級管理

■第四級管理(**噪音性聽力損失**)

十一、「應處理及注意事項」(可複選)

■ 2.檢查結果部分異常，請參照醫師評語，實施健康追蹤檢查

■ 3.檢查結果異常，建議**不適宜從事 噪音 作業**(原因: **噪音性聽力損失**)。

■ 5.檢查結果異常，建議調整工作(可複選)：
□縮短工作時間□更換工作內容■變更作業場所(原因)□其他：

■ 6.其他:定期健檢追蹤。事業單位須進行聽力防護計畫，並請勞工健康服務醫師追蹤評估。

一般及特殊體格(健康)檢查記錄格式 https://www.osha.gov.tw/1106/29647/1141/13440/

(編號2) 噪音作業管理分級

管理分級定義	健康檢查結果管理分級建議
第一級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，全部項目正常，或部分項目異常，而經醫師綜合判定為無異常者。	1. 檢查結果符合下列條件之一： 1.1 法定健康檢查項目無異常發現，或異常結果於追蹤時恢復正常。 1.2 法定健康檢查項目有異常發現，經醫師認定不需於下年度相同特殊健康檢查類別實施前接受健康追蹤檢查。
第二級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，而與工作無關者。	1. 法定健康檢查項目有異常發現，經醫師認定需於下年度相同特殊健康檢查類別實施前接受健康追蹤檢查；如聽力檢查結果依三分法〔(0.5K+1K+2K)/3〕計算，平均聽力損失≥25分貝。 2. 異常項目可由工作以外的原因解釋，如經醫師判定為中耳炎、藥物或外傷引起之非職業性聽力損失。
第三級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，而無法確定此異常與工作之相關性，應進一步請職業醫學科專科醫師評估者。	1. 法定健康檢查或健康追蹤檢查項目有異常發現，且異常項目符合噪音作業的健康危害表現，經醫師綜合判定需請職醫科醫師評估與工作之相關性。 2. 異常結果符合下列條件之一： 2.1 聽力檢查呈現4或6K凹陷，4K或6K聽力損失大於40分貝以上或高音頻平均聽力〔(3K+4K+6K)/3〕比低音頻平均聽力〔(0.5K+1K+2K)/3〕損失≥10分貝以上。 2.2 異常結果無法由工作以外的原因解釋，或事業單位未提供足以判定之作業環境測定或聽力防護記錄。 3. 噪音性聽力損失為兩耳對稱性、以高頻區為主之感覺神經性聽力損失；若雙耳非對稱性聽力損失，應評估是否有單側中耳或內耳病變等複合性成因。
第四級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，且與工作有關者。 早期噪音性聽力損失 為噪音性聽力損失	1. 法定健康檢查或健康追蹤檢查項目有異常發現，且異常項目符合噪音作業的健康危害表現。 2. 聽力防護計畫或噪音作業限制： 2.1 聽力檢查結果三分法〔(0.5K+1K+2K)/3〕平均聽力損失小於25分貝，且出現4或6 K凹陷(聽力損失大於40分貝以上)，加註"為早期噪音性聽力損失，事業單位須進行聽力防護計畫"。 2.2 聽力檢查結果三分法〔(0.5K+1K+2K)/3〕平均聽力損失大於或等於25分貝，且出現4 K或6 K凹陷。高音頻平均聽力〔(3K+4K+6K)/3〕損失大於低音頻平均聽力〔(0.5K+1K+2K)/3〕損失10分貝以上。加註"為噪音性聽力損失，事業單位須進行聽力防護及配工計畫"。 2.3 三分法〔(0.5K+1K+2K)/3〕平均聽力損失與前一年度檢查結果比較變化少於10分貝，可每年實施健康檢查或追蹤檢查，加註"事業單位須進行聽力防護計畫"。 3. 聽力損失為兩耳對稱性、以高頻區為主之感覺神經性聽力損失；若雙耳非對稱性聽力損失，應評估是否有單側中耳或內耳病變等複合性成因。

《噪音作業管理分級參考》

ys591@ms2.hinet.net

A. 全國勞工健康檢查資料庫登錄平台

https://hcd.osha.gov.tw/Login.aspx

安全衛生署

ND HEALTH ADMINISTRATION MINISRY OF LABOUR

| 自然人憑證登入 | 醫事人員憑證登入 | 忘記密碼

| 管理者帳號/母帳號申請 | 登錄平臺介紹 | 認可醫療機構操作手冊下載 | 憑證常見問題



最新消息

111.06.09
法規 - 勞工職業災害保險及保護法自111年5月1日起施行，有關預防職業病健康檢查及健康追蹤檢查之檢查項目、申請方式及應備書件請至勞工保險局全球資訊網（網址：https://www.bli.gov.tw）查詢。

111.06.08
公告 - 自111年5月1日起新增預防職業病健康追蹤檢查業務

111.06.02
公告 - 111年6月2日特別危害健康作業勞工特殊體格及健康檢查記錄表更新

111.03.29
公告 - 勞工保險預防職業病健康檢查證明單紀錄表使用期限說明

111.01.11 ys591@ms2.hinet.net

五、系統操作說明 健檢通報-網頁通報（WEB通報）

網頁通報（WEB通報）注意事項

I檔　D檔　P檔　S檔　X檔　Q檔



檢查主類別僅限選擇31項之特殊作業，選擇須由小至大，不得空欄



請依通報資料選擇版本。108年1月1日開始健檢的條碼一律選1071009



若檢查結果為3或4級，臨床診斷欄位須填寫內容

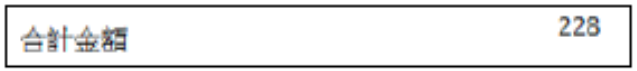


依檢查類別、條碼排序後，由1開始遞增

可不填，系統會自動排序給予編號



診察費會按醫院層級自動給予所對應之支付點數



系統會自動計算診察費及檢查費之加總

若為非勞保局補助，診察費及檢查費欄位可不填

系統使用說明 - 健檢登錄 4 - 網頁申報（WEB 申報）4

網頁申報（WEB申報）注意事項

I檔　D檔　P檔　S檔　X檔　Q檔

辦理勞工體格與健康檢查醫療機構認可及管理辦法
第15條第2項「醫療機構辦理噪音作業勞工檢查結果之管理分級判讀時，應由耳鼻喉科專科醫師或職業醫學科專科醫師為之」。
第16條第2項「聽力檢查結果管理分級判讀，得由符合第十五條第二項資格之醫師，至該認可醫療機構辦理」。
因應法規需求，調整D檔健檢醫師證號及健檢醫師姓名欄位申報方式，以利後續健檢醫師資格勾稽

健檢醫師

證號：
012345
姓名：
林華佗

(1)如遇申報噪音作業，D檔健檢醫師證號及健檢醫師姓名可允許申報兩位醫師資料。
(2)輸入方式為A醫師@B醫師，前面為判讀醫師，後面為健檢醫師，以@做區隔。
(3)如該勞工同時做高溫+噪音+石綿，則填報方式為A醫師+B醫師@C醫師+D醫師，不同作業以+做區隔。

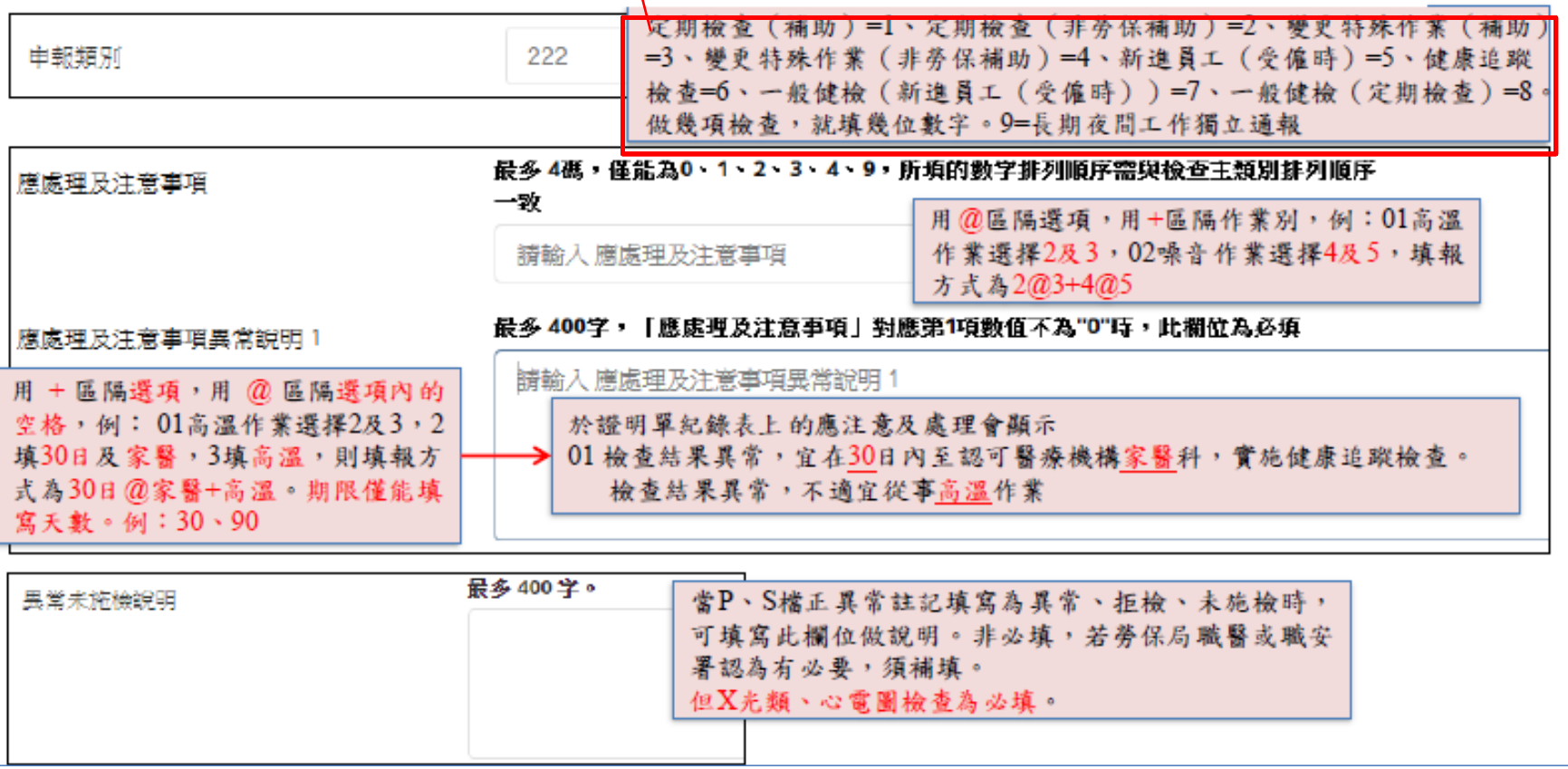
健檢醫師證號，請以醫事人員證書字號（醫字第030000號）格式申報，避免無法介接及勾稽

五、系統操作

網頁通報（WEB通報）注意事項

I檔　D檔

	特殊健檢	舉例
3	變更特殊作業(勞保補助)	游離輻射作業(核能廠)
4	變更特殊作業(非補助)	游離輻射作業
5	新進員工(受僱時)	
6	健康追蹤檢查	



網頁通報（WEB通報）注意事項

十一、應處理及注意事項

十一、應處理及注意事項（可複選）
1.□檢查結果大致正常，請定期健康檢查。填0
2.□檢查結果異常，宜在（期　限）內至認可醫療機構＿＿科，實施健康追蹤檢查。填1
3.□檢查結果異常，建議不適宜從事＿＿＿作業（請說明原因：＿）。填2
4.□檢查結果異常，應在（期　限）內至聘有職業醫學科專科醫師之門診實施健康追蹤檢查。填3
5.檢查結果異常，建議調整工作（可複選）：
　□縮短工作時間（請說明原因：＿＿）。填4a
　□更換工作內容（請說明原因：＿＿）。填4b
　□變更作業場所（請說明原因：＿＿）。填4c
　□其他：＿＿＿＿（請說明原因：＿＿）。填4d
6.□其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。填9

只須要填寫空格內容即可，如（期　限）、＿＿科、＿＿＿作業、請說明原因：＿＿＿。
如非1-5的說明，請選擇6，其他：＿＿＿＿，敘明應處理及注意事項

勞工健康保護規則 第十三條
第二級管理以上者，應由醫師註明其不適宜從事之作業與其他應處理及注意事項；
屬於第三級管理或第四級管理者，並應由醫師註明臨床診斷。

為利於後續勾稽之用，期限，僅限填數字，如90、180等，而非日期，如105年4月30日，或30日、60天等

1.第一級，只能選0、1、9
2.第二級，不能選0、3
3.第三級、第四級，不能選0，及須填D檔臨床診斷欄位

十一、應處理及注意事項

十一、應處理及注意事項（可複選）
1.□檢查結果大致正常，請定期健康檢查。填0
2.□檢查結果異常，宜在（期　限）內至認可醫療機構____科，實施健康追蹤檢查。填1
3.□檢查結果異常，建議不適宜從事_____作業（請說明原因：___）。填2
4.□檢查結果異常，應在（期　限）內至聘有職業醫學科專科醫師之門診實施健康追蹤檢查。填3
5.檢查結果異常，建議調整工作（可複選）：
　□縮短工作時間（請說明原因：____）。填4a
　□更換工作內容（請說明原因：____）。填4b
　□變更作業場所（請說明原因：____）。填4c
　□其他：_____（請說明原因：____）。填4d
6.□其他：_____。填9

範例1
2，1，60@耳鼻喉
範例2
3，3@4c，30+白血球異常
範例3
3122，2@3+0+1+1，鉛@健檢異常+30；；90@胸腔；90@胸腔

範例1
A勞工實施02噪音作業，判2級，注意事項為檢查結果異常，宜在60日內至認可醫療機構耳鼻喉科，實施健康追蹤檢查

範例2
B勞工實施03游離輻射作業，判3級，注意事項為檢查結果異常，應在30日內至聘有職業醫學科專科醫師之門診實施健康追蹤檢查。檢查結果異常，建議調整工作，變更作業場所（請說明原因：白血球異常）。

範例3
C勞工實施05鉛作業、12正己烷作業、18石綿作業、23粉塵作業，各判3級、1級、2級、2級。05鉛作業注意事項為檢查結果異常，建議不適宜從事鉛作業（請說明原因：健檢異常），檢查結果異常，應在30日內至聘有職業醫學科專科醫師之門診實施健康追蹤檢查；12正己烷作業注意事項為檢查結果大致正常，請定期健康檢查；18石綿作業注意事項為檢查結果異常，宜在90日內至認可醫療機構胸腔科，實施健康追蹤檢查； 23粉塵注意事項為檢查結果異常，宜在90日內至認可醫療機構胸腔科，實施健康追蹤檢查。

,	區隔分級/事項/說明
@	區隔選項/ 內的空格
+	區隔作業/ 選項
;	(說明) 區隔作業別

十一、應處理及注意事項

系統使用說明 - 健檢登錄 4 - 網頁申報（WEB 申報）6

網頁申報（WEB申報）注意事項

十一、應處理及注意事項（可複選）
1.□檢查結果大致正常，請定期健康檢查。填0
2.□檢查結果異常，宜在（期　限）內至醫療機構＿＿科，實施健康追蹤檢查。填1
3.□檢查結果異常，建議不適宜從事＿＿＿作業（請說明原因：＿）。填2
4.□檢查結果異常，應在（期　限）內至聘有職業醫學科專科醫師之門診實施健康追蹤檢查。填3
5.檢查結果異常，建議調整工作（可複選）：
□縮短工作時間（請說明原因：＿＿）。填4a
□更換工作內容（請說明原因：＿＿）。填4b
□變更作業場所（請說明原因：＿＿）。填4c
□其他：＿＿＿＿（請說明原因：＿＿）。填4d
6.□其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。填9

十、健康管理	十一、應處理及注意事項（可複選）								
□第一級管理 □第二級管理 □第三級管理（應註明臨床診斷）□第四級管	0	1	2	3	4a	4b	4c	4d	9
	1.□檢查結果大致正常，請定期健康檢查。	2.□檢查結果異常，宜在（期限）內至醫療機構＿科，實	3.□檢查結果異常，建議不適宜從事＿＿作業（請說	4.□檢查結果異常，應在（期限）內至聘有職業醫學科專	5.□檢查結果異常，建議調整工作（可複選）：				6.□其他：
					□縮短工作時間（請說明原因：	□更換工作內容（請說明原因：	□變更作業場所（請說明原因：	□其他：＿＿＿＿（請說明原因：	

B.勞工健康保護管理報備資訊系統 https://hrpts.osha.gov.tw/hrpm/





勞工健康三級管理通報

勞工姓名	身分證號 (外籍人士請填居留證號)	護照號碼 (外籍人士必填)	出生日期 yyymmdd (民國年月日)	特別危害健康作業類別	健檢日期 yyymmdd (民國年月日)	原健檢結果分級級數	原健檢醫院代碼 (請填指定醫療機	原健檢分級判定之醫師姓名	健康追蹤檢查日期 yyymmdd (民國年	重新分級級數	重新分級之職業醫學科專科醫師	重新分級之職業醫學科專科醫師姓	重新分級之職業醫學科專科醫師是	事業單位採行措施						備註
														未採行相關措施 (Y：是；	危害控制 (Y：是；空白：	調離原工作 (Y：是；空白：	調整工時 (Y：是；空白：	其他 (請於備註欄摘述重點)	因故無法追蹤檢查 (請於備	

特別危害健康作業類別	健檢日期 yyymmdd (民國年月日) 例: 1020122	原健檢結果分級級數	原健檢醫院代碼 (請填指定醫療機構代碼，可至資訊網首頁查詢)	原健檢分級判定之醫師姓名	健康追蹤檢查日期 yyymmdd (民國年月日) 例: 1020122	重新分級級數	重新分級之職業醫學科專科醫師姓名	重新分級師執業登
2:噪音	1 1071	3	153		0327	2	楊慎絢	台北市立
2:噪音	1 1211	3	153		0327	4	楊慎絢	台北市立
2:噪音	1 1211	3	153		0327	2	楊慎絢	台北市立
2:噪音	1 1071	3	153		0327	2	楊慎絢	台北市立
2:噪音	1 1141	3	153		0327	2	楊慎絢	台北市立
2:噪音	1 1141	3	153		0327	2	楊慎絢	台北市立
2:噪音	1 1211	3	153		0327	2	楊慎絢	台北市立
2:噪音	1 1071	3	153		0327	2	楊慎絢	台北市立

重新分級之職業醫學科專科醫師是否實施現場評估 (0：未實施現場評估；1：已實施現場評估)	事業單位採行措施						備註
	未採行相關措施 (Y：是；空白：否)	危害控制 (Y：是；空白：否)	調離原工作 (Y：是；空白：否)	調整工時 (Y：是；空白：否)	其他 (請於備註欄摘述重點) (Y：是；空白：否)	因故無法追蹤檢查 (請於備註欄摘述原因) (Y：是；空白：否)	
		Y		Y			聽力防護計劃
		Y	Y	Y	Y		聽力防護計劃，並縮短暴露
		Y		Y			聽力防護計劃

2.【其他經中央主管機關指定公告者】

針對噪音作業環境，可參考「事業單位改善工作環境及促進職場勞工身心健康補助作業要點修正規定」，評估工作環境及製程設施改善方案，例如：噪音消除設備、隔(吸)音箱(板)、隔音罩、隔(吸)音材質包覆、隔振墊、阻尼處理裝置或消音器等。

https://www.osha.gov.tw/media/7189596/111%e5%81%b0%e5%8b%95%e9%83%a8%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%04%b9%e5%06%84%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e7%92%b0%e5%a2%83%e5%8f%8a%e4%bf%83%e9%80%b2%e8%81%b7%e5%a09%4%e5%8b%0e%e5%b7%a5%e8%ba%ab%e5%bf%83%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e8%a6%81%e9%bb%9e-0330-%e6%a2%9d%e6%06%87%e8%88%87%e9%09%84%e8%a1%a8.pdf

Q	辦理勞工健檢之醫療機構，應如何通報健檢結果? 健檢後幾天內通報? (*幾天內重新分級?幾天內通報?)	
A	醫療機構	健檢之日起60天內通報。
	* 事業單位	第三級管理者之健康追蹤檢查(重新分級)，並無明定辦理期限。
		分級結果及採行措施，於檢查後30日內完成通報。

辦理勞工體格及健康檢查之醫療機構，應如何通報勞工健康檢查之結果?

分享

回上一頁 友善列印 轉寄友人

https://www.osha.gov.tw/1106/1196/10101/10116/10117/13892/

查「辦理勞工體格與健康檢查醫療機構認可及管理辦法」第18條之規定，認可醫療機構對於勞工健康檢查之結果，應依中央主管機關公告之內容、方式及期限，辦理通報。勞動部業以106年1月19日勞職授字第1050204999號公告，經勞動部認可之勞工特殊體格及健康檢查醫療機構，應於辦理勞工特殊健康檢查之日起60日內完成通報，通報系統之網址，請至勞動部職業安全衛生署網站(https://www.osha.gov.tw)/主題網站/全國勞工健康檢查資料庫登錄平台。

Q	**噪音判定3級 是否可以臨場服務模式到事業單位評估判斷? 不用在醫院留下病歷嗎?**
A	事業單位可請 所僱用或特約職業醫學科專科醫師入廠服務重新分級。

特殊健檢後勞工健康管理列為3級，應在何期限內進行健康追蹤檢查及通報？

分享

回上一頁 友善列印 轉寄友人

https://www.osha.gov.tw/1106/1196/10101/10116/10118/10861/

一、勞工健康保護規則第21條及勞動部107年7月2日勞職授字第1070203046號公告規定，特殊健檢結果為第三級管理者，應請職業醫學科專科醫師實施健康追蹤檢查，必要時應實施疑似工作相關疾病之現場評估，且應依評估結果重新分級，並將分級結果及採行措施依中央主管機關公告之方式於檢查後30日內完成通報，其目的係為落實職場健康分級管理作為，強化職業病預防，保障勞工權益

二、第三級管理者之健康追蹤檢查係由職業醫學專科醫師辦理即可，尚無醫療機構之限制，事業單位可請所僱用或特約職業醫學科專科醫師入廠服務重新分級；另該健康追蹤檢查並無明定辦理期限，得由檢查之醫師依個案狀況提供建議，於建議之期限內，使勞工進行健康追蹤檢查並依規定完成通報。

(編號3) 游離輻射作業健檢

TSH	參考值0.35~4.94 uIU/ml
Free T4	參考值0.70-1.48 ng/dl

八、檢查項目

1. 基本項目：身高___公
   視力(矯正
2. 各系統或部位身體檢
   (1)頭、頸部【眼睛（含白內障）、甲狀腺結節、腫瘤、淋巴結】
   (2)心臟
   (3)肺臟
   (4)神經系統
   (5)消化系統
   (6)泌尿系統
   (7)骨骼、關節、肌肉
   (8)皮膚
3. 心智及精神狀況
4. 胸部X光：_____
5. 肺功能檢查（包括用力肺活量(FVC)、一秒最大呼氣量($FEV_{1.0}$)）
6. 甲狀腺功能檢查：free T4_____、TSH_____
7. 生化血液檢查：血清丙胺酸轉胺酶(ALT)_____ 肌酸酐(creatinine)_____
8. 血液檢查：紅血球數_____ 血色素_____ 血球比容值_____
   白血球數_____ 白血球分類_____ 血小板數_____
9. 尿液檢查：尿糖____ 尿蛋白____ 尿潛血____ 尿沉渣鏡檢(細胞學診斷)____

、編號3游離輻射作業甲狀腺功能檢查之T3易受其他因素干擾，爰修正為以free T4取代T3及T4；另肺功能檢查目的係考量配戴呼吸防護具者，需評估勞工呼吸之生理功能，然基於目前除核能電廠或廢料貯存場從事運

備註：

肺功能檢查為新進勞工之特殊體格或變更作業者之檢查項目，在職勞工之特殊健康檢查，無須檢測此項目；但於核能電廠或廢料貯存場作業者，仍需進行本項檢測。

ys591@ms2.hinet.net

2. 各系統或部位身體檢查：

(1)頭、頸部【眼睛（含白內障）、甲狀腺結節、腫瘤、淋巴結】 ☐無異狀 ☐異常;異常結果說明：

(2)心臟 ☐無異狀 ☐異常;異常結果說明：

(3)肺臟 ☐無異狀 ☐異常;異常結果說明：

(4)神經系統 ☐無異狀 ☐異常;異常結果說明：

(5)消化系統 ☐無異狀 ☐異常;異常結果說明：

(6)泌尿系統 ☐無異狀 ☐異常;異常結果說明：

(7)骨骼、關節、肌肉 ☐無異狀 ☐異常;異常結果說明：

(8)皮膚 ☐無異狀 ☐異常;異常結果說明：

3. 心智及精神狀況 ☐無異狀 ☐異常;異常結果說明：

4. 胸部 X 光：☐正常 ☐異常;異常結果說明：_____

_____

台灣電力公司

游離輻射作業勞工特殊體格及健康檢查紀錄

（承攬商或短期支援人員用）

https://www.kln.mohw.gov.tw/public/ufile/c439ebff4a2c9063865246618c3fd4ab.pdf

5. 肺功能檢查：用力肺活量(FVC) _____%;一秒最大呼氣量($FEV_{1.0}$) _____%；$FEV_{1.0}$/FVC _____%

6. 甲狀腺功能檢查：Free T4_____ng/dL、TSH_____ uIU/ml

7. 生化血液檢查：血清丙胺酸轉胺酶(ALT)_____ U/L、肌酸酐(creatinine) _____ mg/dl

8. 血液檢查：白血球數_____10^3/ul 、血色素_____g/dl、血球比容值_____%
紅血球數_____10^6/ul、血小板數_____10^3/ul、 白血球分類(如下)

9. 尿液檢查：尿糖_____mg/dL 、尿蛋白_____ mg/dL、尿潛血_____ mg/dL
尿沉渣鏡檢(細胞學診斷)(如下)

白血球分類計數

Neut(嗜中性白血球)：_____%

Lymp(淋巴球)：_____%

Mono(單核球)：_____%

Eosin(嗜酸性白血球)：_____%

Baso(嗜鹼性白血球)：_____%

尿沉渣鏡檢

RBC(紅血球)：_____

WBC(白血球)：_____

EPI(上皮細胞)：_____

BAC(細菌) ：_____

ys591@ms2.hinet.net

十一、應處理及注意事項（可複選）

1. □檢查結果大致正常，請定期健康檢查。
2. □檢查結果異常，宜在（期限　　）內至醫療機構　　科，實施健康追蹤檢查。
3. □檢查結果異常，建議不適宜從事下列作業（請說明原因）。

□游離輻射作業（不得進入輻射管制區工作）

原因：

□惡性腫瘤：

□血液疾病：

□內分泌疾病：

□精神與神經異常：

□眼睛疾病：

□其他：

原因：

台灣電力公司

游離輻射作業勞工特殊體格及健康檢查紀錄

（承攬商或短期支援人員用）

https://www.kln.mohw.gov.tw/public/ufile/c439ebff4a2c9063865246618c3fd4ab.pdf

4. □檢查結果異常，應在（期限　　）內至聘有職業醫學科專科醫師之門診實施健康追蹤檢查。
5. □檢查結果異常，建議調整工作（可複選）：

□縮短工作時間（請說明原因：　　）。

□更換工作內容（請說明原因：　　）。

□不宜單獨操作

原因：

□變更作業場所（請說明原因：　　）。

□不宜進入放射性污染區工作（不可穿戴防護衣物、裝具及使用去污藥品）

原因：

□不宜進入空浮放射性區工作（不可穿戴面罩）

原因：

□其他：　　（請說明原因：　　）。

6. □其他：

□佩帶面罩適可性分類：

□不可戴面罩（不宜進入空浮區工作）

□限制戴面罩（不宜戴面罩，但必要時可佩帶，唯必須有人陪伴工作，發現不適時，應立即離開現場，取下面罩）

□可以戴面罩

□其他：

ys591@ms2.hinet.net

(編號3) 游離輻射作業管理分級

三、管理分級建議 (資料來源：中華民國環境職業醫學會專家會議)

管理分級定義	健康檢查結果管理分級建議
第一級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，全部項目正常，或部分項目異常，而經醫師綜合判定為無異常者。	1. 檢查結果符合下列條件之一： 1.1 法定健康檢查項目無異常發現，或異常結果於追蹤時恢復正常。 1.2 法定健康檢查項目有異常發現，經醫師認定不需於下年度相同特殊健康檢查類別實施前接受健康追蹤檢查。
第二級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，而與工作無關者。	1. 法定健康檢查項目有異常發現，經醫師認定需於下年度相同特殊健康檢查類別實施前接受健康追蹤檢查。 2. 異常項目可由工作以外的原因解釋，如肝功能異常可由B、C型肝炎、脂肪肝、肥胖、高血脂、喝酒等工作以外的原因解釋，或蛋白尿，經醫師綜合判定需繼續追蹤檢查。
第三級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，而無法確定此異常與工作之相關性，應進一步請職業醫學科專科醫師評估者。	1. 法定健康檢查或健康追蹤檢查項目有異常發現，且異常項目符合游離輻射作業的健康危害表現，經醫師綜合判定需請職醫科醫師評估與工作之相關性。 2. 異常結果符合下列條件之一： 2.1 異常項目符合游離輻射作業的健康危害表現，如血球數減少(特別是是淋巴球)、疑似白血病、甲狀腺功能低下或甲狀腺癌；或疑似輻射性相關疾病或異常，如皮膚炎(潰瘍、乾燥、薄、脫屑、紅或後續之色素沈著、脫毛)或皮膚癌、肺炎或肺纖維化、骨癌、白內障等。 2.2 異常結果無法由工作以外的原因解釋，或事業單位未提供足以判定之作業環境測定或劑量計(配章)等記錄。
第四級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，且與工作有關者。	1. 法定健康檢查項目或健康追蹤檢查結果全部或部分異常，且異常項目符合游離輻射作業的健康危害表現，如血球數減少(特別是是淋巴球)、疑似白血病、甲狀腺功能低下或甲狀腺癌、輻射性皮膚炎(潰瘍、乾燥、薄、脫屑、紅或後續之色素沈著、脫毛)或皮膚癌、輻射性肺炎或肺纖維化、骨癌、白內障等。 2. 異常結果可由工作相關原因解釋。

(編號3) A先生46歲「游離輻射作業健檢」

	白血球數3800/ul (參考值3900~10800/ul)，其他項目均正常。
	意見1.游離輻射作業:白血球數目偏低，應視為異常，建議判定為第2級管理。 意見2.「法定健康檢查項目有異常發現，經醫師認定不需於下年度相同特殊健康檢查類別實施前接受健康追蹤檢查。」因此列為第1級管理。

十、健康管理: □第一級管理 ■第二級管理
□第三級管理(臨床診斷)　□第四級管理(臨床診斷)

十一、「應處理及注意事項」(可複選)

	1.檢查結果大致正常，請定期健康檢查。
■	2.檢查結果部分異常，宜在3M內至 內科，健康追蹤檢查
	3.檢查結果異常，建議不適宜從事____作業(原因　　) 。
	4.檢查結果異常，應在___內至聘有職業醫學科專科醫師之門診實施健康追蹤檢查。
	5.檢查結果異常，建議調整工作(可複選)： □縮短工作時間□更換工作內容□變更作業場所(原因) □其他：
	6.其他(請說明)：

一般及特殊體格(健康)檢查記錄格式 https://www.osha.gov.tw/1106/29647/1141/13440/

(編號3) B小姐38歲「游離輻射作業健檢」

TSH	<0.0083 uIU/ml	<0.0083	參考值0.35~4.94 uIU/ml
Free T4	2.29 ng/dl	1.63 ng/dl	參考值0.70-1.48 ng/dl
健康管理	第三級(2021.6.11)	第二級(2021.6.16)	

十、健康管理: □第一級管理 □第二級管理 (原)特殊健檢
■第三級管理(臨床診斷:甲狀腺功能亢進) □第四級管理(臨床診斷)

十、健康管理: □第一級管理 ■第二級管理 重新分級
□第三級管理(臨床診斷) □第四級管理(臨床診斷)

十一、「應處理及注意事項」(可複選)

1.檢查結果大致正常，請定期健康檢查。

■ 2.檢查結果部分異常，宜在3M內至 內科，健康追蹤檢查

特別危害健康作業類別	健檢日期 yyymmdd (民國年月日) 例: 1020122	原健檢結果分級級數	原健檢醫院代碼 (請填指定醫療機構代碼，可至資訊	原健檢分級判定之醫師姓名	健康追蹤檢查日期 yyymmdd (民國年月日) 例:	重新分級級數	重新分級之職業醫學科專科醫師姓名	重新分級之職業醫學科專科醫師執業登錄	重新分級之職業醫學科專科醫師是否實施	事業單位採行措施						備註
										未採行相關措施 (Y：是；空白：否)	危害控制 (Y：是；空白：否)	調離原工作 (Y：是；空白：否)	調整工時 (Y：是；空白：否)	其他 (請於備註欄摘述重點) (Y：是；空白：	因故無法追蹤檢查 (請於備註欄摘述原因)	
3:游離輻		73				22	楊慎絢	桃園敏盛	1		Y			Y		甲狀腺功亢進，新代謝科門追蹤診治若有不適

V	項目名稱	結果	N	前次結果	前次日期	參考值	單位
□	TSH	< 0.0083	L	0.0083	110.06.11	0.35 - 4.94	uIU/mL
□	Free-T4	1.63	H	2.29	110.06.11	0.70 - 1.48	ng/dL

ys591@ms2.hinet.net

5 鉛作業 (特殊健檢) 血中鉛

2. 各系統或部位身體檢查：
   (1)齒齦鉛線
   (2)血液系統（貧血）
   (3)消化系統
   (4)神經系統
   (5)腎臟系統
3. 血中鉛檢查_____
4. 血液檢查：紅血球數_____ 血色素_____ 血球比容值_____
5. 尿液檢查：尿蛋白____ 尿潛血____

6 四烷基鉛作業 (特殊健檢) 尿中鉛

2. 各系統或部位身體檢查：
   (1) 心臟血管
   (2) 神經系統
   (3) 皮膚
   (4) 精神狀態
3. 尿液檢查：尿蛋白____ 尿潛血____
4. 尿中鉛檢查：_____

ys591@ms2.hinet.net

5 鉛作業 (特殊健檢)

第三級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，而無法確定此異常與工作之相關性，應進一步請職業醫學科專科醫師評估者。	1. 法定健康檢查項目或健康追蹤檢查結果全部或部分異常，且異常項目符合鉛作業的健康危害表現，經醫師綜合判定需請職醫科醫師評估與工作之相關性。 2. 異常結果符合下列條件之一： 2.1 異常項目符合鉛中毒的健康危害表現，如尚不知原因之小球性低血色素、周邊神經病變(如垂腕或垂足等伸肌麻痺或感覺異常)、腎臟病變(如蛋白尿達二價(≥ 100 mg/dL))。 2.2 血中鉛濃度男性≥ 40μg /dL、女性≥ 30 μg /dL。 2.3 異常結果無法由工作以外的原因解釋，或事業單位未提供足以判定之作業環境測定記錄。
第四級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，且與工作有關者。	1. 法定健康檢查項目或健康追蹤檢查結果全部或部分異常，且異常項目符合鉛作業的健康危害表現。 2. 異常結果符合下列條件： 2.1 異常項目符合鉛中毒的健康危害表現，如出現鉛性腹絞痛等消化道症狀、齒齦鉛緣(有鉛沉澱之鉛線)、小球性低血色素貧血(排除缺鐵性貧血及海洋性貧血)、周邊神經病變(如垂腕或垂足等伸肌麻痺或感覺異常)、或腎臟病變(如蛋白尿達二價(≥ 100 mg/dL))等。 2.2 血中鉛濃度男性≥ 40 μg /dL或女性≥ 30 μg /dL。

	男性	女性
血鉛	≥ 40 ug/dL	≥ 30 ug/dL

四、健康管理附註資料

健康管理分級	建　議
第一級管理	無特殊規定
第二級管理 **第三級管理** **第四級管理**	1. 考量不適合從事作業之疾病：神經系統疾病、貧血等血液疾病、腎臟疾病、消化系統疾病、肝病、內分泌系統疾病、視網膜病變、酒精中毒、高血壓。(資料來源：勞工健康保護規則第十三條及附表三十八) 1.1 精神或神經系統疾病包含癲癇 1.2 內分泌系統疾病包含糖尿病 2 暫時停止暴露(medical removal)標準參考值：血中鉛濃度≥ 60 μg /dL、最近三次或最近六個月檢查平均值≥ 50 μg/dL (以檢查期間較長者之平均值為準)。(資料來源：Occupational Safety and Health Standards - Lead. 1910.1025(k), US Department of Labor)

	暫時停止暴露
血鉛	≥ 60 ug/dL
	≥ 50 ug/dL (近3次/近6m)

6 四烷基鉛作業 (特殊健檢)

三、管理分級建議 (資料來源：中華民國環境職業醫學會專家會議)

管理分級定義	健康檢查結果管理分級建議
第一級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，全部項目正常，或部分項目異常，而經醫師綜合判定為無異常者。	1. 檢查結果符合下列條件之一： 1.1 法定健康檢查項目無異常發現，或異常結果於追蹤時恢復正常。 1.2 法定健康檢查項目有異常發現，經醫師認定不需於下年度相同特殊健康檢查類別實施前接受健康追蹤檢查。
第二級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，而與工作無關者。	1. 法定健康檢查項目有異常發現，經醫師認定需於下年度相同特殊健康檢查類別實施前接受健康追蹤檢查。 2. 異常項目可由工作以外的原因解釋，如泌尿道結石或感染引起的血尿、尿蛋白等，經醫師綜合判定需繼續追蹤檢查。
第三級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，而無法確定此異常與工作之相關性，應進一步請職業醫學科專科醫師評估者。 6 四烷基鉛 尿鉛 ≥ 150 ug/L	1. 法定健康檢查項目或健康追蹤檢查結果全部或部分異常，且異常項目符合四烷基鉛作業的健康危害表現。 2. 異常結果符合下列條件之一： 2.1 異常項目符合四烷基鉛中毒的健康危害表現，如中樞神經病變(如四肢深部肌腱反射增加)或精神異常(如焦慮、失眠、夢魘或記憶障礙等)、或腎臟病變(如蛋白尿達二價(≥100 mg/dL))等。 2.2 尿中鉛濃度≥150 μg/L。 3. 異常結果無法由工作以外的原因解釋，或事業單位未提供足以判定之作業環境測定記錄。
第四級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，且與工作有關者。 6 四烷基鉛 尿鉛 ≥ 150 ug/L	1. 法定健康檢查項目或健康追蹤檢查結果全部或部分異常，且異常項目符合四烷基鉛作業的健康危害表現。 2. 異常結果符合下列條件之一，事業單位須定期實施健康追蹤檢查，並進行鉛危害防護及配工計劃： 2.1 異常項目符合四烷基鉛中毒的健康危害表現，如中樞神經病變(如四肢深部肌腱反射增加)或精神異常(如焦慮、失眠、夢魘或記憶障礙等)、或腎臟病變(如蛋白尿達二價(≥100 mg/dL))等。 2.2 尿中鉛濃度≥150 μg/L。

(編號19) 砷作業管理分級

八、檢查項目

1. 基本項目：身高___公分；體重___公斤；腰圍___公分；血壓___/___mmHg
   視力(矯正)：左___右___；辨色力測試：□正常 □辨色力異常
2. 各系統或部位身體檢查：
   (1)鼻腔
   (2)呼吸系統
   (3)神經系統
   (4)腸胃系統
   (5)皮膚
3. 胸部X光：_____
4. 血液檢查：紅血球數_____ 血色素_____ 血球比容值_____ 白血球數_____
5. 生化血液檢查：血清丙胺酸轉胺酶(ALT)_____ 加瑪麩胺醯轉移酶(r-GT)_____
6. 尿液檢查：尿蛋白_____ 尿潛血_____ 尿沉渣鏡檢(細胞學檢查)_____
7. 尿中無機砷檢查：(包括三價砷、五價砷、單甲基砷、雙甲基砷及尿液肌酸酐之各項檢驗數值)

九、健康追蹤檢查

1. 檢查日期___年___月___日
2. 檢查項目
   (1)_____
   (2)_____
   (3)_____
   (4)_____
   (5)_____

尿砷及代謝物	≥ 30 ug/g Cr (或 ≥ 35 ug/L)
(且)三價砷與五價砷	≥ 10 ug/L

ys591@ms2.hinet.net

A19先生46歲「砷作業健檢」

無機砷總量79.5 μg/g CRE，三價砷2.4 μg/L，五價砷<2.7 μg/L，單甲基砷3.1 μg/L，雙甲基砷138.8 μg/L。(尿液肌酸酐 181.6 mg/dL)

十、健康管理: □第一級管理　79.5 μg/g CRE = 79.5 μg/ (1.816 g/L) =43.70 μg/L

■第二級管理 □第三級管理(臨床診斷)　□第四級管理(臨床診斷)

十一、「應處理及注意事項」(可複選)

1.檢查結果大致正常，請定期健康檢查。

■ 2.檢查結果部分異常，宜在3M內至 內科，健康追蹤檢查

3.檢查結果異常，建議不適宜從

4.檢查結果異常，應在___內至

尿砷及代謝物	≥ 30 ug/g Cr (或 ≥ 35 ug/L)
(且)三價砷與五價砷	≥ 10 ug/L

三價及五價砷的無機砷化合物，在人體攝入後，五價砷會代謝成三價砷，再代謝成一甲基砷(monomethylarsonic acid, MMA)及二甲基砷(dimethylarsinic acid, DMA)，尿液為其主要的代謝途徑，因此尿液中與無機砷有關的砷物種，主要包括 As3+、As5+、MMA 及 DMA 四項，由於尿液中的砷包含了有機砷與無機砷的部分，所以我們可以針對此四項無機砷物種尿液中的濃度作偵測，來作為人體中慢性無機砷中毒的指標。

一般及特殊體格(健康)檢查記錄格式　https://www.osha.gov.tw/1106/29647/1141/13440/

(編號19) 砷作業管理分級

第一級管理

特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，全部項目正常，或部分項目異常，而經醫師綜合判定為無異常者。

1. 檢查結果符合下列條件之一：
   1.1 法定健康檢查項目無異常發現，或異常結果於追蹤時恢復正常。
   1.2 法定健康檢查項目有異常發現，經醫師認定不需於下年度相同特殊健康檢查類別實施前接受健康追蹤檢查。

第二級管理

特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，而與工作無關者。

1. 法定健康檢查項目有異常發現，經醫師認定需於下年度相同特殊健康檢查類別實施前接受健康追蹤檢查。
2. 異常項目可由工作以外的原因解釋，如飲食因素造成之砷濃度偏高、缺鐵性貧血、尿路感染或尿路結石引起之尿液檢查異常，經醫師綜合判定需繼續追蹤檢查。

第三級管理

特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，而無法確定此異常與工作之相關性，應進一步請職業醫學科專科醫師評估者。

尿砷及代謝物	≥ 30 ug/g Cr (或 ≥ 35 ug/L)
(且)三價砷與五價砷	≥ 10 ug/L

1. 法定健康檢查或健康追蹤檢查項目有異常發現，且異常項目符合砷作業的健康危害表現，經醫師綜合判定需請職醫科醫師評估與工作之相關性。
2. 異常結果符合下列條件之一：
   2.1 理學檢查發現鼻中膈粘膜潰瘍或穿孔，末梢神經炎、皮膚暴露部位色素沉著或角化、疑似皮膚癌或肝臟腫瘤等症狀。
   2.2 血液檢查(白血球、紅血球或血小板)至少一項低於正常、胸部X光出現疑似肺部腫瘤、蛋白尿達二價(≥ 100 mg/dL)、或有肝臟病變(如肝臟腫大、腫瘤、或肝功能異常)等變化。
   2.3 尿中砷及其代謝物檢驗值合計數≥ 30 μg/g Creatinine (或≥ 35 μg/L)，且三價與五價砷離子濃度≥ 10 μg/L

第四級管理

特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，且與工作有關者。

1. 法定健康檢查或健康追蹤檢查項目有符合砷中毒的健康危害表現。
2. 異常結果符合下列條件之一：
   2.1 理學檢查發現鼻中膈粘膜潰瘍或穿孔，末梢神經炎、皮膚暴露部位色素沉著或角化、疑似皮膚癌或肝臟腫瘤等症狀。
   2.2 血液檢查(白血球、紅血球或血小板)至少一項低於正常、胸部X光出現疑似肺部腫瘤、蛋白尿達二價(≥ 100 mg/dL)、或有肝臟病變(如肝臟腫大、腫瘤、或肝功能異常)等變化。
   2.3 尿中砷及其代謝物檢驗值合計數≥ 30 μg/g Creatinine (或≥ 35 μg/L)，且三價與五價砷離子濃度≥ 10 μg/L。

ys591@ms2.hinet.net

砷及其化合物作業__變更作業者: 無須檢測「單甲基砷」及「雙甲基砷」，無須檢測「無機砷」(3價砷,5價砷)

尿中無機砷檢查：(變更作業者無須檢測單甲基砷及雙甲基砷)

八、檢查項目

1. 基本項目：身高___公分；體重___公斤；腰圍___公分；血壓___/___mmHg
   視力(矯正)：左___右___；辨色力測試：□正常 □辨色力異常
2. 各系統或部位身體檢查：
   (1)鼻腔
   (2)呼吸系統
   (3)神經系統
   (4)腸胃系統
   (5)皮膚
3. 胸部 X 光：_____
4. 血液檢查：紅血球數_____ 血色素_____ 血球比容值_____ 白血球數_____
5. 生化血液檢查：血清丙胺酸轉胺酶(ALT)_____ 加瑪麩胺醯轉移酶(r-GT)_____
6. 尿液檢查：尿蛋白_____ 尿潛血_____ 尿沉渣鏡檢(細胞學檢查)_____
7. 尿中無機砷檢查：(包括三價砷、五價砷、單甲基砷、雙甲基砷及尿液肌酸酐之各項檢驗數值(變更作業者無須檢測單甲基砷及雙甲基砷)

尿中無機砷檢查為在職勞工之特殊健康檢查項目，新進勞工之特殊體格或變更作業者無須檢測。

備註：

尿中無機砷檢查為在職勞工之特殊健康檢查項目，新進勞工之特殊體格或變更作業者無須檢測。

ys591@ms2.hinet.net

一般及特殊體格(健康)檢查記錄格式 https://www.osha.gov.tw/1106/29647/1141/13440/

A19先生36歲 「變更作業」從事「砷作業」健檢

尿中無機砷總量25.4 μg/g CRE，三價砷 1.4 μg/L，五價砷 0.4μg/L
(尿液肌酸酐 105.78 mg/dL)

十、健康管理: □第一級管理
□第二級管理 □第三級管理(臨床診斷) □第四級管理(臨床診斷)

十一、「應處理及注意事項」(可複選)

1.檢查結果大致正常，請定期健康檢查。

2.檢查結果部分異常，宜在 內至 科，健康追蹤檢查

3.檢查結果異常，建議不適宜從

4.檢查結果異常，應在___內至

尿砷及代謝物	≥ 30 ug/g Cr (或 ≥ 35 ug/L)
(且)三價砷與五價砷	≥ 10 ug/L

三價及五價砷的無機砷化合物，在人體攝入後，五價砷會代謝成三價砷，再代謝成一甲基砷(monomethylarsonic acid, MMA)及二甲基砷(dimethylarsinic acid, DMA)，尿液為其主要的代謝途徑，因此尿液中與無機砷有關的砷物種，主要包括 As3+、As5+、MMA 及 DMA 四項，由於尿液中的砷包含了有機砷與無機砷的部分，所以我們可以針對此四項無機砷物種尿液中的濃度作偵測，來作為人體中慢性無機砷中毒的指標。

一般及特殊體格(健康)檢查記錄格式 https://www.osha.gov.tw/1106/29647/1141/13440/

(編號23) 粉塵作業管理分級

三、管理分級建議 (資料來源：中華民國環境職業醫學會專家會議)

管理分級定義	健康檢查結果管理分級建議
第一級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，全部項目正常，或部分項目異常，而經醫師綜合判定為無異常者。	1. 檢查結果符合下列條件之一： 1.1 法定健康檢查項目無異常發現，或異常結果於追蹤時恢復正常。 1.2 法定健康檢查項目有異常發現，經醫師認定不需於下年度相同特殊健康檢查類別實施前接受健康追蹤檢查。
第二級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，而與工作無關者。	1. 法定健康檢查項目有異常發現，經醫師認定需於下年度相同特殊健康檢查類別實施前接受健康追蹤檢查。 2. 異常項目可由工作以外的原因解釋，如陳舊性肺結核在肺尖形成的鈣化性結節，經醫師綜合判定需繼續追蹤檢查。
第三級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，而無法確定此異常與工作之相關性，應進一步請職業醫學科專科醫師評估者。	1. 法定健康檢查或健康追蹤檢查項目有異常發現，且異常項目符合粉塵作業的健康危害表現，經醫師綜合判定需請職醫科醫師評估與工作之相關性。 2. 異常結果符合下列條件之一： 2.1 異常項目符合本項作業的健康危害表現，如疑似ILO胸部X光照像型別第一型或以上之陰影、肺功能有減損或臨床檢查發現其他可能相關之病徵等。 2.2 異常結果無法由工作以外的原因解釋，或事業單位未提供足以判定之作業環境測定記錄。
第四級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，且與工作有關者。	1. 法定健康檢查或健康追蹤檢查項目有異常發現，且異常項目符合粉塵作業的健康危害表現，如符合ILO胸部X光照像型別第一型或以上之陰影、肺功能有減損或臨床檢查發現其他可能相關之病徵等。 2. 異常結果可由工作相關原因解釋。

A23先生50歲 粉塵作業20+年，「粉塵作業健檢」(如圖)



十、健康
□第二級管 斷)
十一、「
1.檢查
2.檢查 檢查
3.檢查

(3) 大陰影
0：無大陰影。
A：一個大陰影之最大寬
不超過五公分。
B：一個大陰影之最大寬
大陰影之最大寬度
兩者間之大陰影)。
C：一個大陰影超過右
面積。

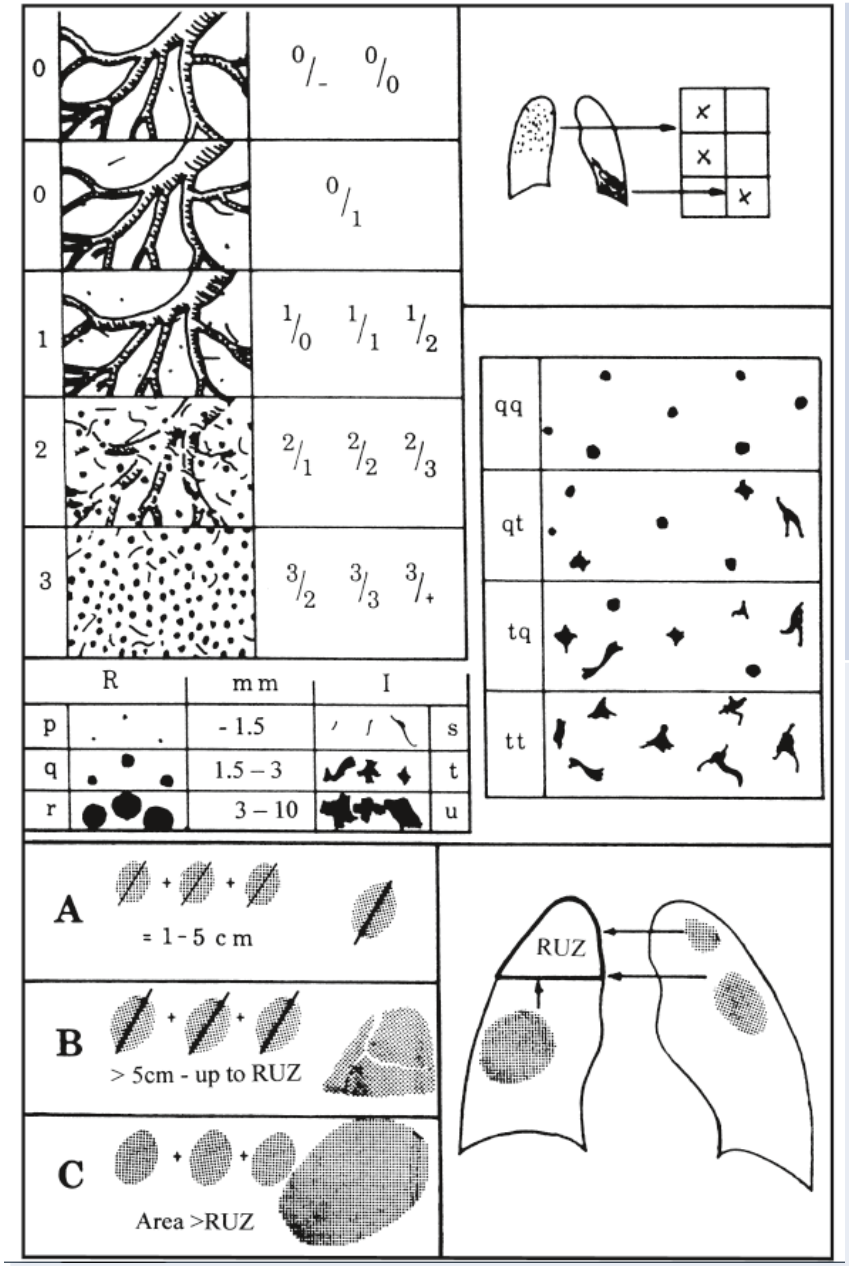
(5) X光照像型別
一型：兩側肺野有明顯
二型：兩側肺野有明顯
三型：兩側肺野有明顯
四型：有明顯的圓型或

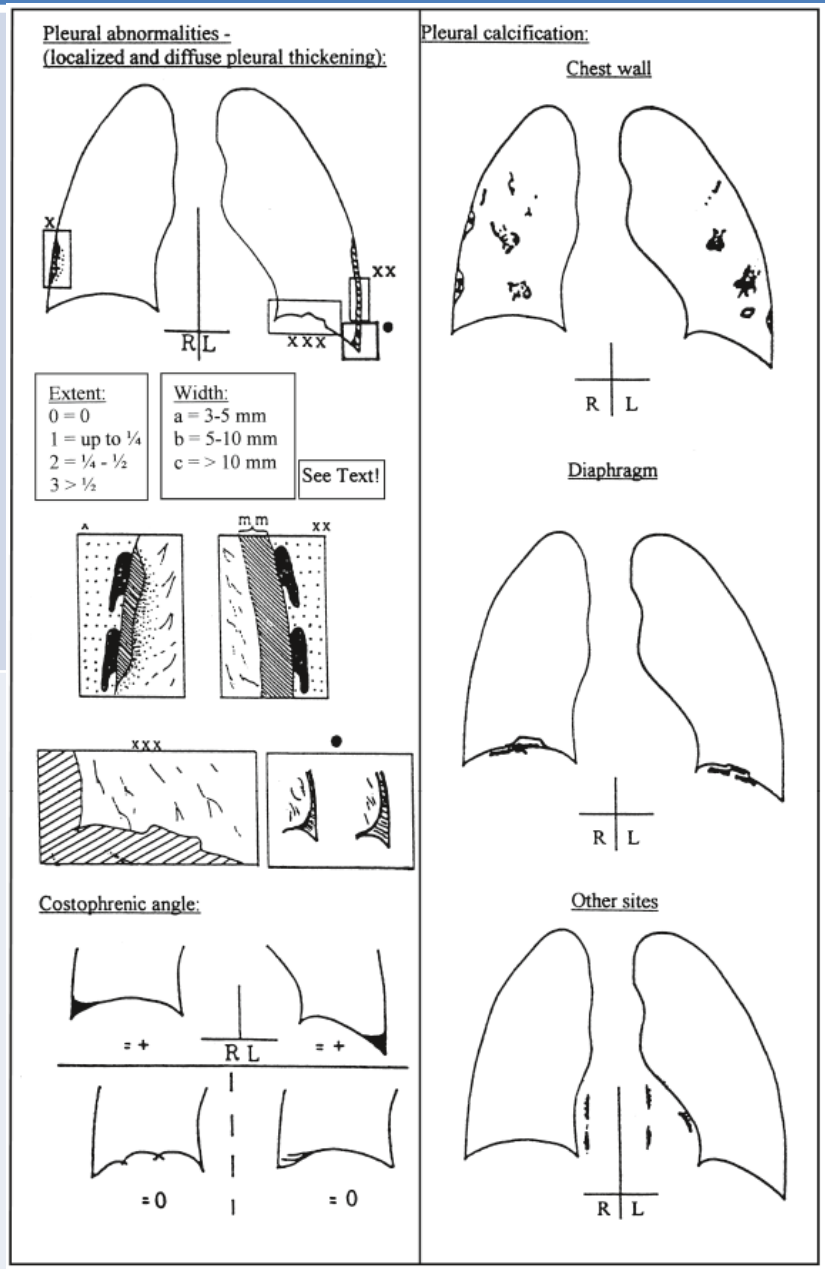
影
明
pa
地：
50
440/

ys591@ms2.hinet.net

粉塵作業CXR健康分級管理

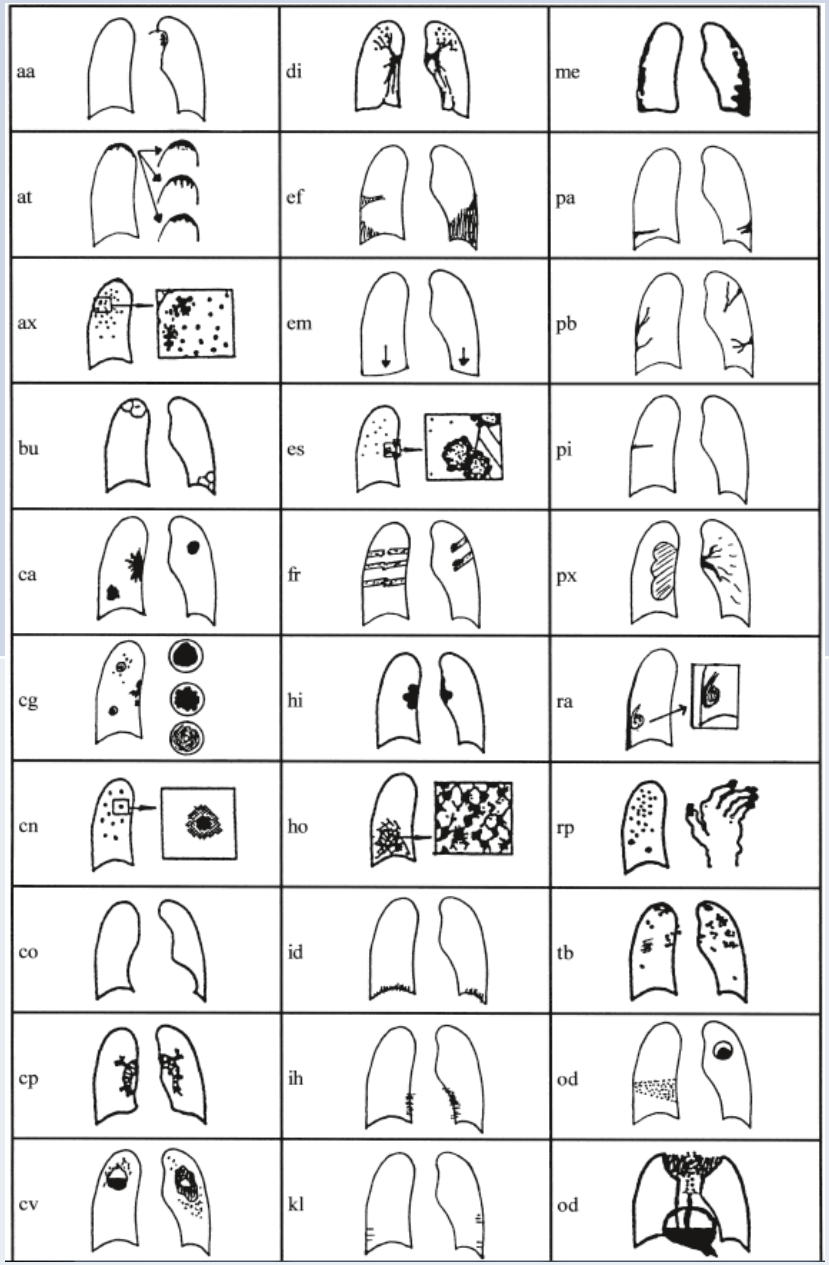
ys591@ms2.hinet.net





粉塵作業CXR健康分級管理

ys591@ms2.hinet.net



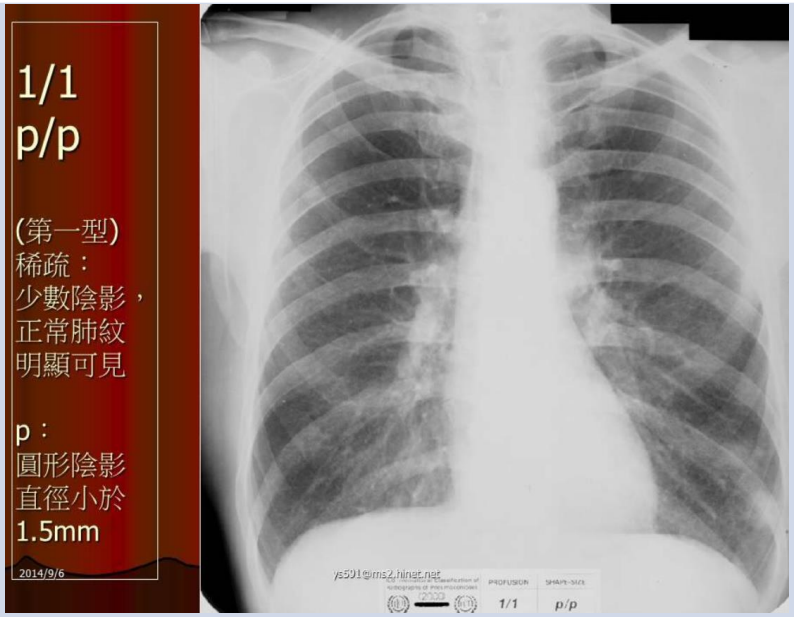
(4) 附加記載事項

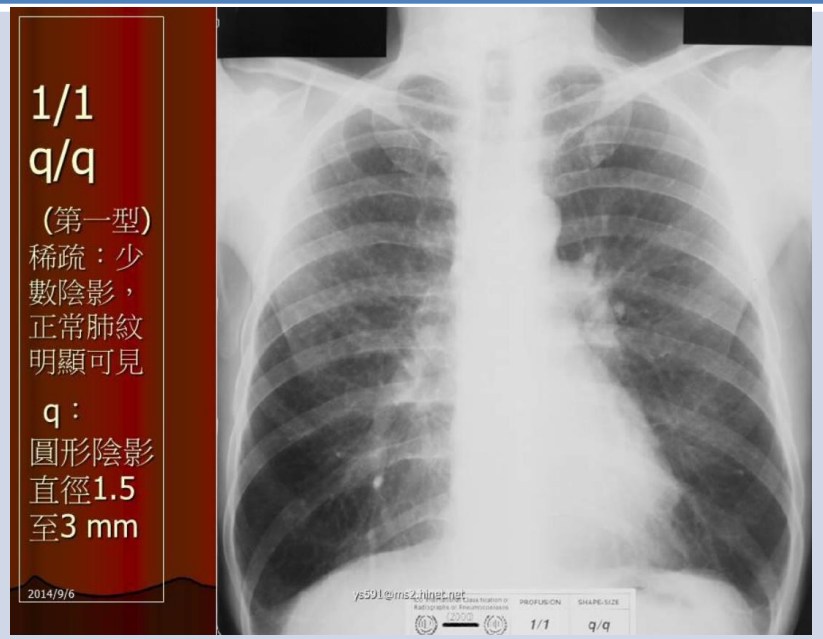
aa：主動脈粥樣硬化。
at：明顯肺尖部肋膜增厚
ax：小陰影融合。
bu：氣泡。
ca：胸腔癌症，不包括間皮細胞瘤。
cg：非塵肺之鈣化小節（如：肉芽腫）或結節。
cn：小塵肺陰影之鈣化。
co：心臟大小或形狀之異常。
cp：肺性心臟病(因肺血管高血壓引致之心臟病)。
cv：空洞。
di：胸腔內的結構之顯著扭曲或變形。
ef：肋膜積液。
em：肺氣腫。
es：肺門或縱隔淋巴結之蛋殼狀鈣化。
fr：肋骨骨折（包括急性或已經癒合）。
hi：非鈣化性肺門或縱隔淋巴結之腫大。
ho：蜂巢狀肺。
id：橫膈膜邊緣輪廓不清的。
ih：心臟邊緣輪廓不清的。
kl: 中隔 (Septal 或 Kerley) 線。
me：間皮細胞瘤。
pa：扁平狀肺膨脹不全。
pb：肺實質內纖維帶狀。
pi：肺葉間裂中之肋膜增厚。
px：氣胸。
ra：圓形肺膨脹不全。
rp：風濕性塵肺症。
tb：肺結核。
od：其他有意義之異常。

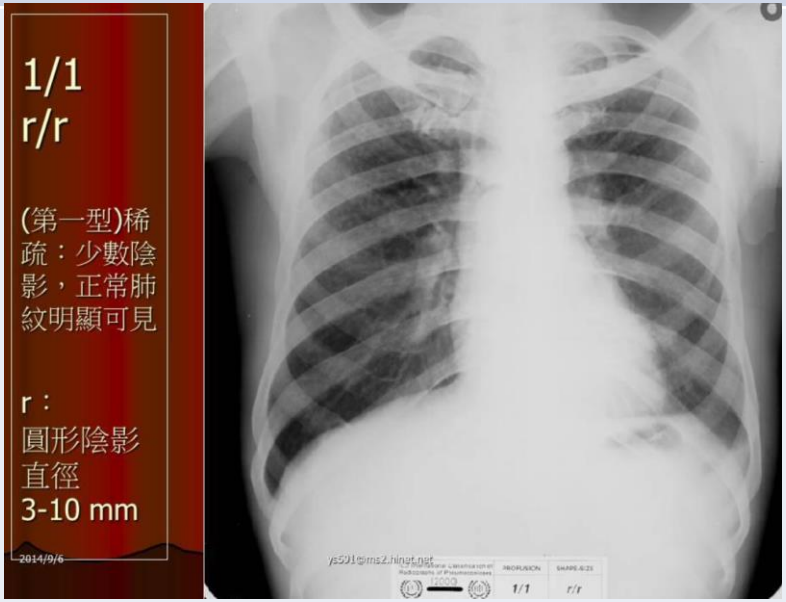
編號23 粉塵作業 勞工特殊體格及健康檢查紀錄
https://www.osha.gov.tw/1106/1119/1141/13440/13575/

粉塵作業CXR健康分級管理

ys591@ms2.hinet.net







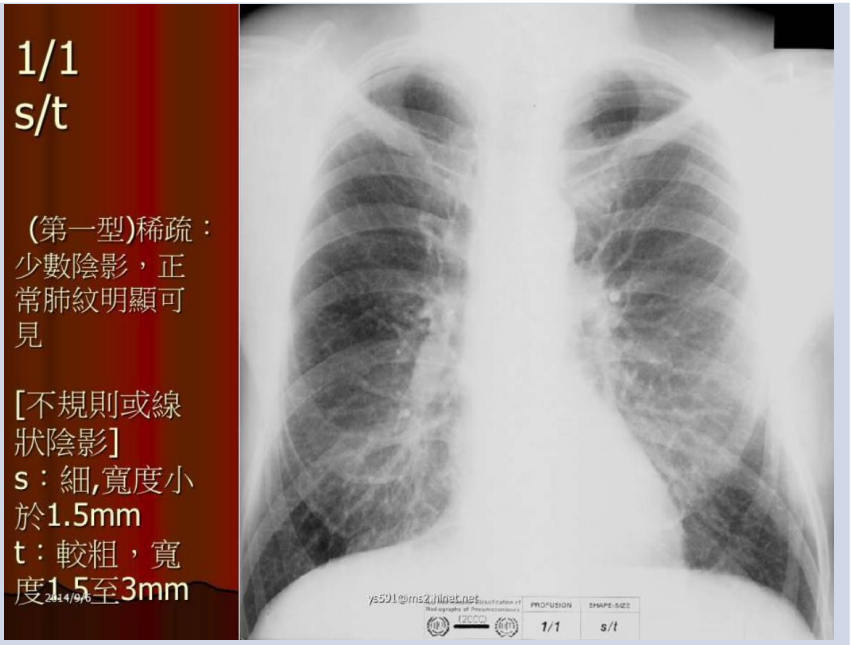
3. 胸部 X 光：

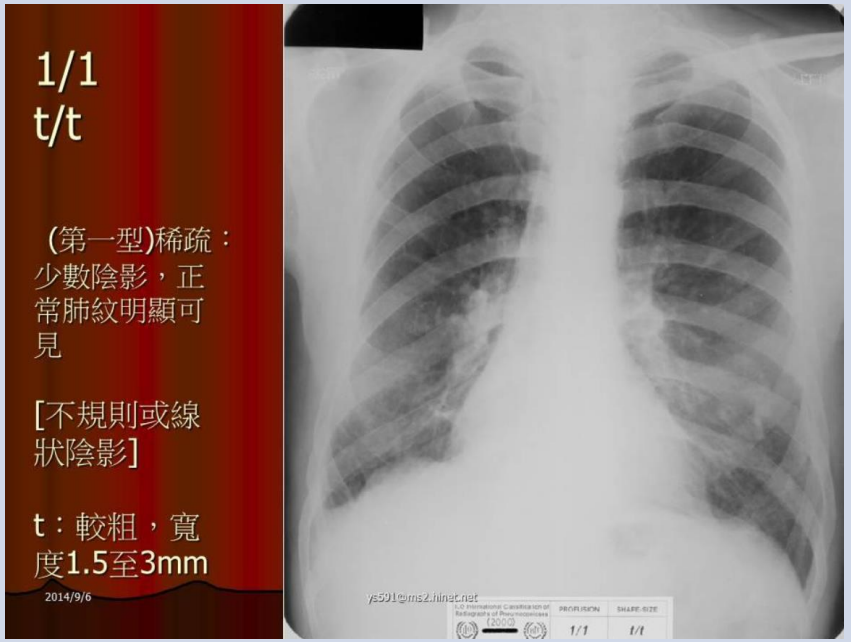
肺	小陰影					
	特徵	大小	密度分佈	影響部位		
	圓形陰影	P q r	0 1 2 3		上肺部	中肺部	下肺部
	不規則陰影	S t u		左			
				右			
	大陰影：0 A B C					
胸膜	肥厚	肋膜斑（pleural plaque）：無，右，左				
		肋膜增厚（pleural thickening）：無，右，左				
	鈣化：無，右，左					
附加記載事項	aa at ax bu ca cg cn co cp cv di ef em es fr hi ho id ih kl me pa pb pi px ra rp tb od					
X 光照片像型別	正常 一型 二型 三型 四型					

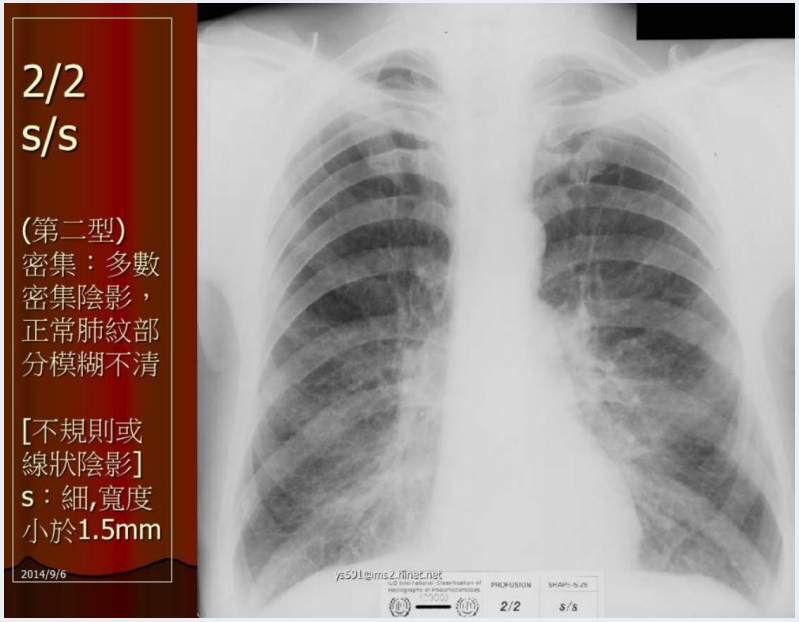
4. 肺功能檢查（包括用力肺活量(FVC)、一秒最大呼氣量($FEV_{1.0}$)及 $FEV_{1.0}$ /FVC）

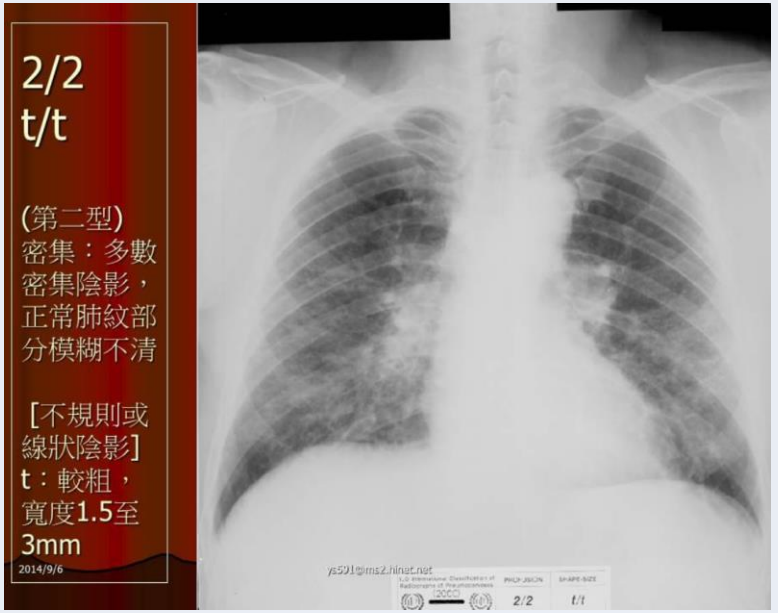
粉塵作業CXR健康分級管理

ys591@ms2.hinet.net



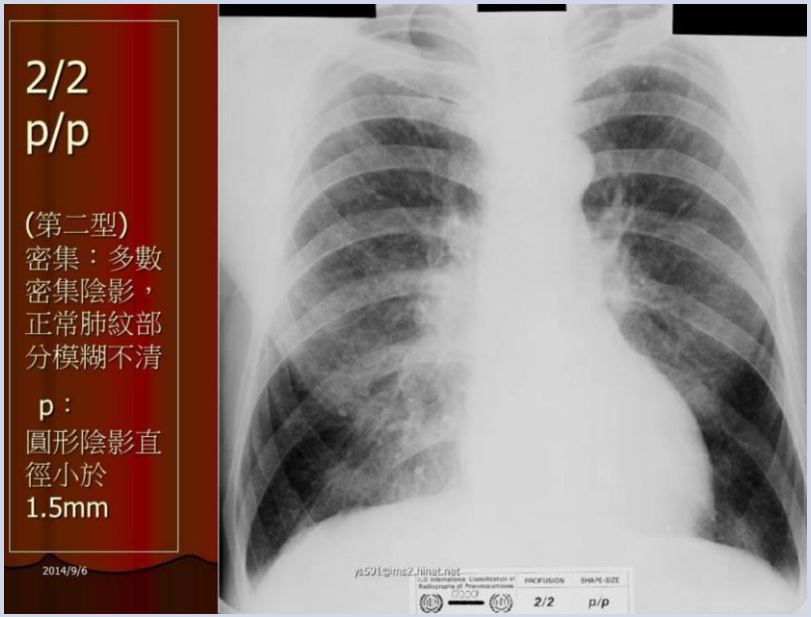




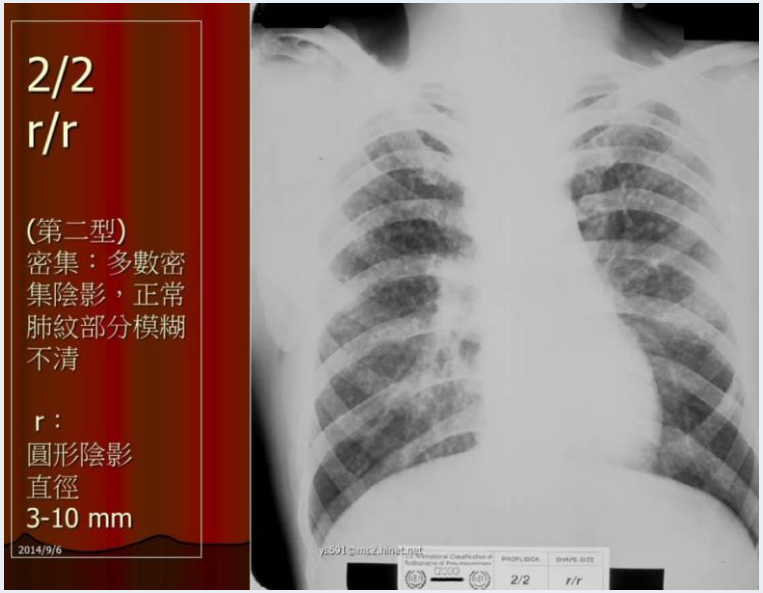


粉塵作業CXR健康分級管理

ys591@ms2.hinet.net







1. X光攝影檢查所載記號之說明

（1）小陰影大小（最大直徑一公分以下者）

p：圓形陰影其直徑小於1.5公釐者。

q：圓形陰影其直徑大於1.5，但不超過3公釐者。

r：圓形陰影其直徑大於3，但不超過10公釐者。

s：不規則陰影其寬度小於1.5公釐者。

t：不規則陰影其寬度大於1.5，但不超過3公釐者。

u：不規則陰影其寬度大於3，但不超過10公釐者。

（2）小陰影密度

0：無小陰影。

1：稀疏（少數陰影）：正常之肺紋理(lung marking)明顯可見。

2：密集（多數密集陰影）：

圓形陰影：正常之肺紋理仍然明顯可見。

不規則陰影：正常之肺紋理部分模糊不清。

3：極密（極多數密集陰影）：

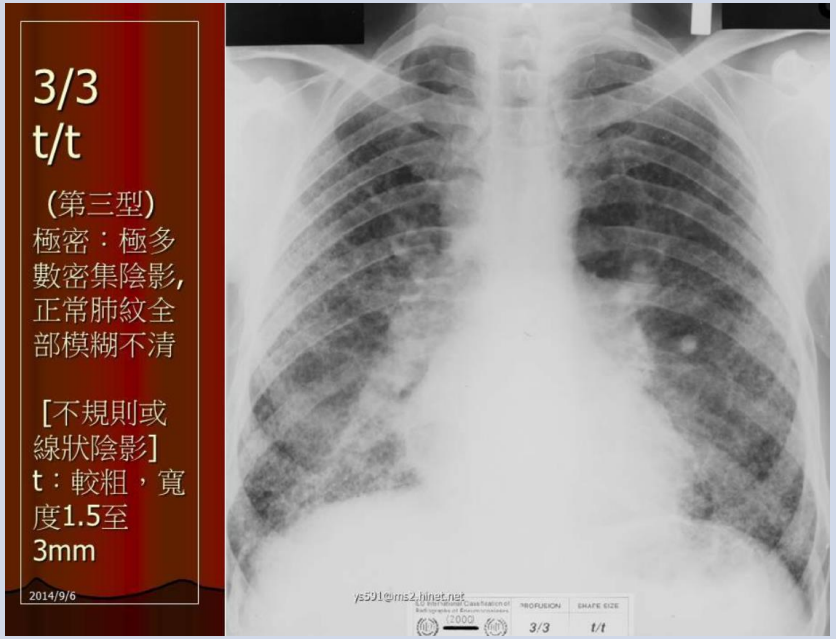
圓形陰影：正常之肺紋理部分或全部模糊不清。

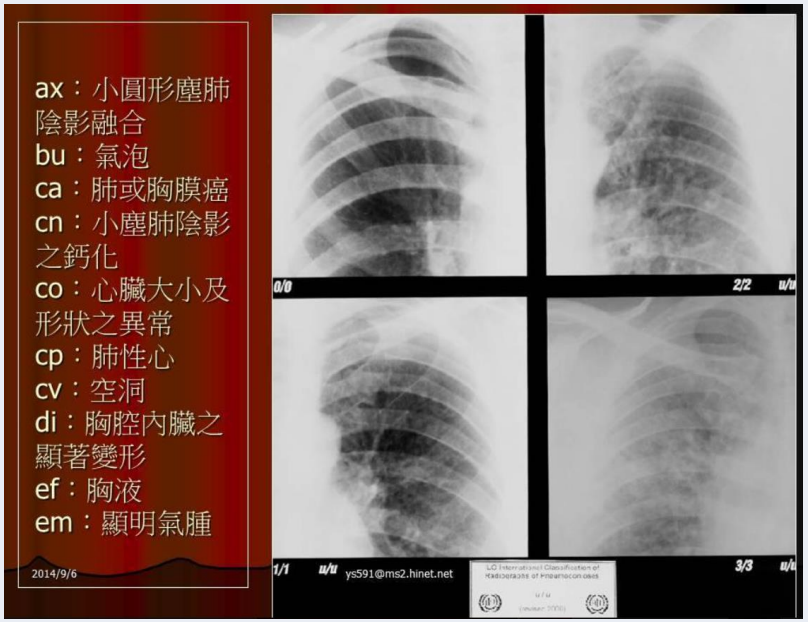
不規則陰影：正常之肺紋理全部模糊不清。

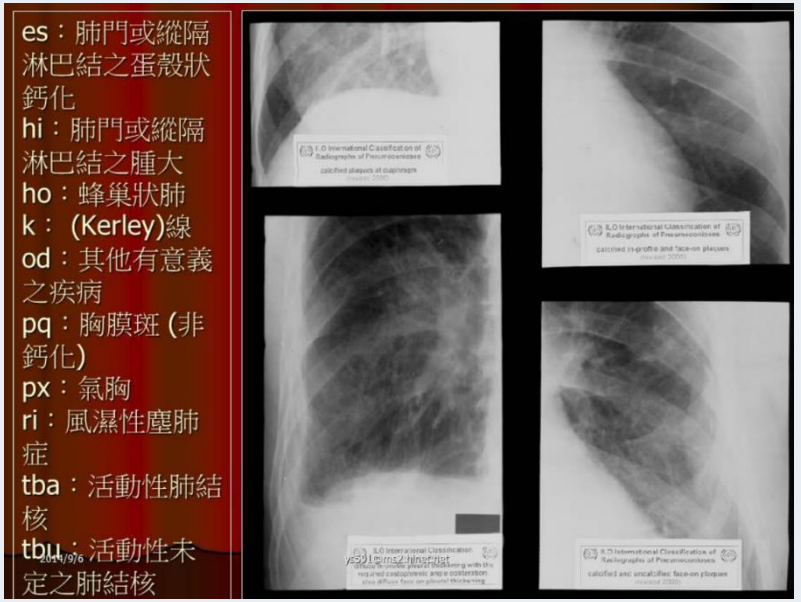
粉塵作業CXR健康分級管理

ys591@ms2.hinet.net



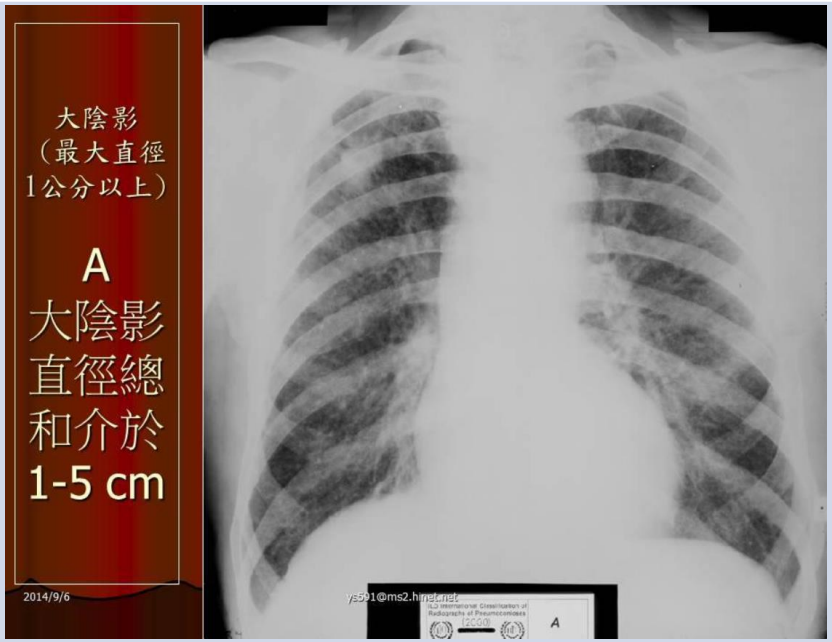


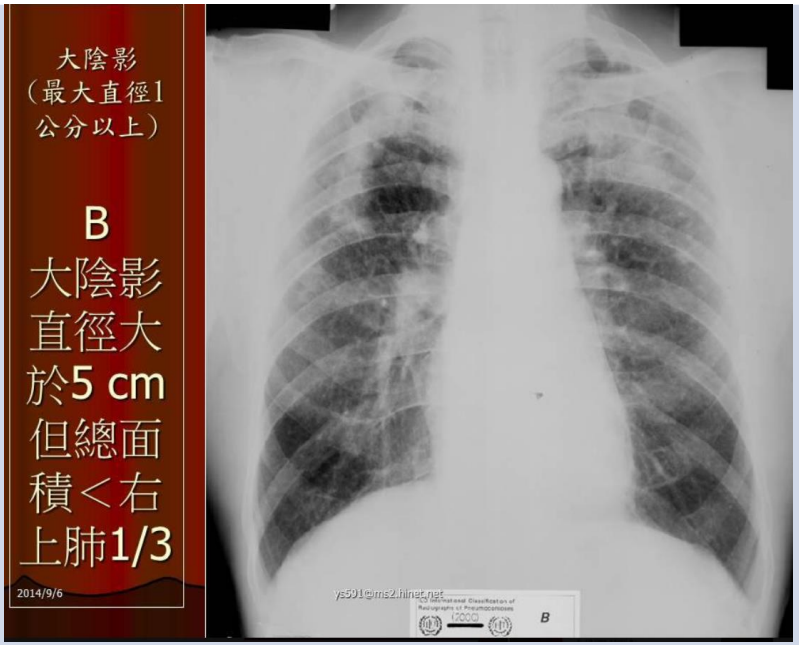


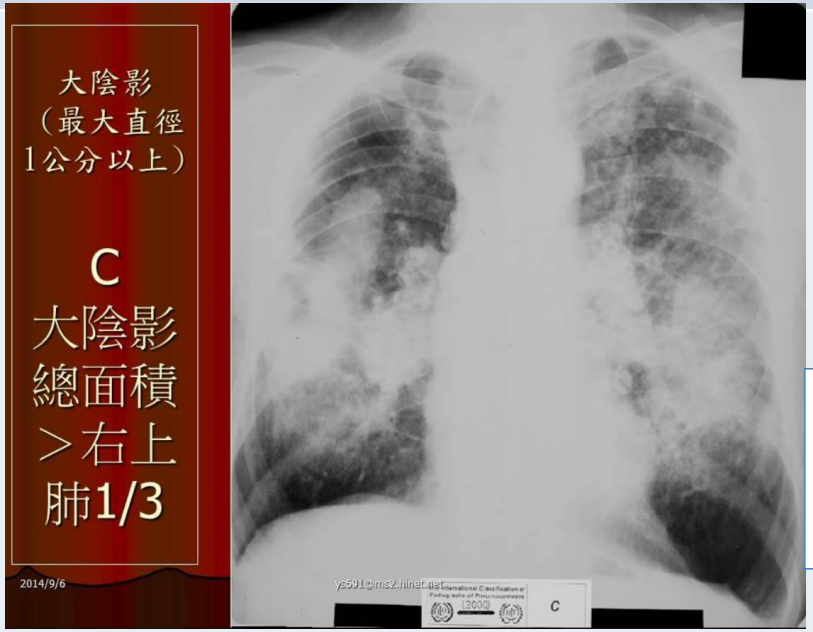


粉塵作業CXR健康分級管理

ys591@ms2.hinet.net







（3）大陰影

0：無大陰影。

A：一個大陰影之最大寬度不超過五公分，或多個大陰影之最大寬度總和不超過五公分。

B：一個大陰影之最大寬度超過五公分，但未超過右上肺區域之面積，或多個大陰影之最大寬度總和超過五公分但未超過右上肺區域之面積（介於AC兩者間之大陰影）。

C：一個大陰影超過右上肺區域之面積，或多個大陰影總和超過右上肺區域之面積。

（5）X光照像型別

一型：兩側肺野有明顯而分佈稀疏之圓型或不規則陰影，但無大陰影者

二型：兩側肺野有明顯而分佈密集之圓型或不規則陰影，但無大陰影者

三型：兩側肺野有明顯而分佈極密之圓型或不規則陰影，但無大陰影者

四型：有明顯的圓型或不規則陰影，且有大陰影者。

C：一個大陰影超過右上肺區域之面積，或多個大陰影總和超過右上肺區域之面積。

(5) X光照像型別

一型：兩側肺野有明顯而分佈稀疏之圓型或不規則陰影，但無大陰影者。

二型：兩側肺野有明顯而分佈密集之圓型或不規則陰影，但無大陰影者。

三型：兩側肺野有明顯而分佈極密之圓型或不規則陰影，但無大陰影者。

四型：有明顯的圓型或不規則陰影，且有大陰影者。



十、健康管理: □第一級管理 □第二級管理 □第三級管理(臨床診斷) ■第四級管理(臨床診斷)慢性肺阻塞型疾病

十一、「應處理及注意事項」(可複選)

	1.檢查結果大致正常，請定期健康檢查。
■	2.檢查結果部分異常，宜在1M內至胸腔內科，健康追蹤檢查
■	3.檢查結果異常，建議不適宜從事粉塵作業(原因慢性肺阻塞型疾病)。
■	4.檢查結果異常，應在1M內至聘有職業醫學科專科醫師之門診實施健康追蹤檢查。
■	5.檢查結果異常，建議調整工作(可複選)： □縮短工作時間□更換工作內容■變更作業場所(原因) □其他：
■	6.其他(請說明)：變更至非粉塵作業場所

一般及特殊體格(健康)檢查記錄格式 https://www.osha.gov.tw/1106/29647/1141/13440/

(編號26) 鎳及其化合物作業 管理分級

管理分級定義	健康檢查結果管理分級建議
第一級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，全部項目正常，或部分項目異常，而經醫師綜合判定為無異常者。	1. 檢查結果符合下列條件之一： 1.1 法定健康檢查項目無異常發現，或異常結果於追蹤時恢復正常。 1.2 法定健康檢查項目有異常發現，經醫師認定不需於下年度相同特殊健康檢查類別實施前接受健康追蹤檢查。
第二級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，而與工作無關者。	1. 法定健康檢查項目有異常發現，經醫師認定需於下年度相同特殊健康檢查類別實施前接受健康追蹤檢查。 2. 異常項目可由工作以外的原因解釋，如肝功能異常可由病毒性肝炎、脂肪肝、藥物之服用或飲酒習慣等非職業性因素解釋；或泌尿道感染造成之血尿或蛋白尿；肺部感染或其它病因造成之肺部病變或肺功能異常。
第三級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，而無法確定此異常與工作之相關性，應進一步請職業醫學科專科醫師評估者。	1. 法定健康檢查或健康追蹤檢查項目有異常發現，且異常項目符合鎳作業的健康危害表現，經醫師綜合判定需請職醫科醫師評估與工作之相關性。 2. 異常結果符合下列條件之一： 2.1 有皮膚暴露部位之接觸性或過敏性皮膚炎，鼻中膈穿孔，可能與鎳暴露有關之氣喘、氣管炎、鼻炎和鼻竇炎等異常發現。 2.2 尿中鎳濃度≥ 30 μg/g Creatinine (或45μg/L)。 2.3 異常結果無法由工作以外的原因解釋，或事業單位未提供足以判定之作業環境測定記錄。
第四級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，且與工作有關者。 **尿鎳 ≥ 30 ug/g Cr (或 ≥ 45 ug/L)**	1. 法定健康檢查或健康追蹤檢查項目有異常發現，且異常項目符合鎳作業的健康危害表現。 2. 異常結果符合下列條件之一： 2.1 有皮膚暴露部位之接觸性或過敏性皮膚炎，鼻中膈穿孔，可能與鎳暴露有關之氣喘、氣管炎、鼻炎和鼻竇炎等符合鎳作業之健康危害表現。 2.2 尿中鎳濃度≥ 30 μg/g Creatinine (或45μg/L)。 3. 異常結果可由工作相關原因解釋。

A26小姐47歲「鎳及其化合物作業健檢」

尿中鎳 7.6 µg/g CRE (尿液肌酸酐 161.9 mg/dL)
肺功能：輕度侷促性肺疾變化。

十、健康管理: □第一級管理
■第二級管理 □第三級管理(臨床診斷) □第四級管理(臨床診斷)

十一、「應處理及注意事項」(可複選)

尿鎳	≥ 30 ug/g Cr (或 ≥ 45 ug/L)

1.檢查結果大致正常，請定期健康檢查。

■ 2.檢查結果部分異常，宜在3M內至 內科，健康追蹤檢查

3.檢查結果異常，建議不適宜從事____作業(原因)。

4.檢查結果異常，應在___內至聘有職業醫學科專科醫師之門診實施健康追蹤檢查。

5.檢查結果異常，建議調整工作(可複選)：
□縮短工作時間□更換工作內容□變更作業場所(原因) □其他：

6.其他(請說明)：

一般及特殊體格(健康)檢查記錄格式 https://www.osha.gov.tw/1106/29647/1141/13440/

(編號31) 鈷及其化合物作業 管理分級

第一級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，全部項目正常，或部分項目異常，而經醫師綜合判定為無異常者。	1. 檢查結果符合下列條件之一： 1.1 法定健康檢查項目無異常發現，或異常結果於追蹤時恢復正常。 1.2 法定健康檢查項目有異常發現，經醫師認定不需於下年度相同特殊健康檢查類別實施前接受健康追蹤檢查。
第二級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，而與工作無關者。	1. 法定健康檢查項目有異常發現，經醫師認定需於下年度相同特殊健康檢查類別實施前接受健康追蹤檢查。 2. 異常項目可由工作以外的原因解釋，如(1)陳舊性肺結核在肺尖形成的鈣化性結節；(2)過敏性鼻炎、感冒；(3)氣喘、慢性支氣管炎、慢性肺部阻塞性疾病、過敏性肺炎(hypersensitivity pneumonitis)、原發性肺纖維化(idiopathic pulmonary fibrosis)或肺部腫瘤、類肉瘤症；(4)濕疹、接觸性皮膚炎、皮膚粘膜刺激性炎症(如潰瘍或疣樣突起)、皮膚肉芽腫，經醫師綜合判定需於下年度相同特殊健康檢查類別實施前繼續追蹤檢查。 3. 輔助參考：排除臨床症狀與鈷及其化合物暴露有關之參考值為吸入之空氣濃度<0.01 mg/m^3。
第三級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，而無法確定此異常與工作之相關性，應進一步請職業醫學科專科醫師評估者。	1. 法定健康檢查或健康追蹤檢查項目有異常發現，且異常項目符合鈷及其化合物作業的健康危害表現，經醫師綜合判定需請職業醫學科專科醫師評估與工作之相關性。 2. 異常結果符合下列條件之一： 2.1 有刺激性皮膚炎、結膜角膜刺激性病灶、咳嗽、呼吸困難肺纖維化之症狀、肺部惡性腫瘤等符合鈷及其化合物作業之急性與慢性健康危害表現。 2.2 異常結果無法由工作以外的原因解釋，或事業單位未提供足以判定之作業環境測定記錄。 2.3 血清鈷 ≥3 μg/L。 2.4 輔助參考：鈷及其化合物八小時日時量平均濃度(TWA)≥0.05 mg/m^3(OSHA 建議之管理行動預警閾值) 3. 經職業醫學科專科醫師實施追蹤複檢後，不宜維持第三級管理之判定。如有特殊狀況，須註明無法進一步判定為二級或四級管理的理由。
第四級管理	1. 法定健康檢查或健康追蹤檢查項目有異常發現，且異常項目符合鈷及

血清鈷	≥ 3 ug/ L
TWA	≥ 0.05 mg/ M3

ys591@ms2.hinet.net

(編號31) 鈷及其化合物作業 健康管理

1.化學清單 | 2.處置單位 | 3.儲置方式 | 4.使用方式 | 5.健康管理

四、改善及建議採行措施：

1.【辨識與評估工作場所環境及作業之危害】【健康教育與衛生指導之策劃】

(1).「勞工健康保護規則」2016.3.23 新增「鈷及其化合物」之製造、處置或使用作業為特別危害健康之作業。 |處置或使用「鈷及其化合物」的系所與實驗室包括: 系(實驗室代碼 20)、中心(00)、 系(90)、 系(80)、 (4 0)，並安排 2016.5 下午實地至實驗室評估「鈷及其化合物」處置方式與作業流程(表一)。

表一 處理與置放「鈷及其化合物」的系所

「鈷」原料	處理與置放的系所單位	置放處
顆粒狀	館 6 室 (圖一)	防潮箱
薄片狀	館 9 室(圖二)	防潮箱
粉末狀	館 5 室(圖三)、 館 1 室(圖四)、 館 0 室(圖五)、 館 4 室(圖六)、 館 A 室(圖七)、 館 8 室(圖八、圖九)	防潮箱

(編號31) 鈷及其化合物作業 健康管理

1.化學清單 | 2.處置單位 | 3.儲置方式 | 4.使用方式 | 5.健康管理

表二　使用「鈷及其化合物」的系所與人數		
系所	使用方式	使用人數
館　6室	電焊熔解鈷顆粒(圖一)	1
館　9室	製程以水切研磨鈷片(圖二)	1
館　4室	鈷粉加入水中(圖六)	1

(3).醫師說明金屬「鈷」具急毒性(吸入、食入、皮膚)，吸入鈷粉可能造成咽喉灼熱感、急性肺水腫，長期毒性包括:肝、腎、心臟、造血系統、肺永久傷害，建議作業流程須注意通風與配戴個人防護具(圖十)，在明顯處張貼危害圖式(圖十一)，備安全資料表(化學品全球調和制度 http://ghs.osha.gov.tw/CHT/intro/search.aspx)列入特別危害健康作業健檢(圖十三)，進行健康分級管理。

圖一　館　6室 (鈷金屬顆粒)	圖二　館　9室 (鈷金屬片)
	

ys591@ms2.hinet.net

A31先生27歲「鋦及其化合物作業健檢」

血清鋦 < 0.1 μg/L 。肺功能：中度混合型肺疾變化。

(尿中砷 7.8 μg/g CRE，尿液肌酸酐 49.0 mg/dL)

十、健康管理: □第一級管理

■第二級管理 □第三級管理(臨床診斷)　□第四級管理(臨床診斷)

十一、「應處理及注意事項」(可複選)

1.檢查結果大致正常，請定期健康檢查。

■ 2.檢查結果部分異常，宜在3M內至 內科，健康追蹤檢查

3.檢查結果異常，建議不適宜從事____作業(原因　　)。

4.檢查結果異常，應在___內至聘有職業醫學科專科醫師之門診實施健康追蹤檢查。

血清鋦	≥ 3 ug/ L
TWA	≥ 0.05 mg/ M3

5.檢查結果異常，建議調整工作(可複選)：□縮短工作時間□更換工作內容□變更作業場所(原因) □其他：

6.其他(請說明)：

一般及特殊體格(健康)檢查記錄格式 https://www.osha.gov.tw/1106/29647/1141/13440/

A31小姐39歲「銦及其化合物作業健檢」

血清銦 < 0.1 μg/L 。肺功能：中度混合型肺疾變化。

(尿中鎳 2.6 μg/g CRE，尿液肌酸酐 179.4 mg/dL)

(3)呼吸系統及皮膚黏膜（含眼睛結膜）之身體檢查。	(3)呼吸系統及皮膚黏膜（含眼睛結膜）之身體檢查。

十、健康管理: □第一級管理

■第二級管理 □第三級管理(臨床診斷) □第四級管理(臨床診斷)

十一、「應處理及注意

1.檢查結果大致正

■ 2.檢查結果部分異

3.檢查結果異常，

4.檢查結果異常，
診實施健康追蹤檢

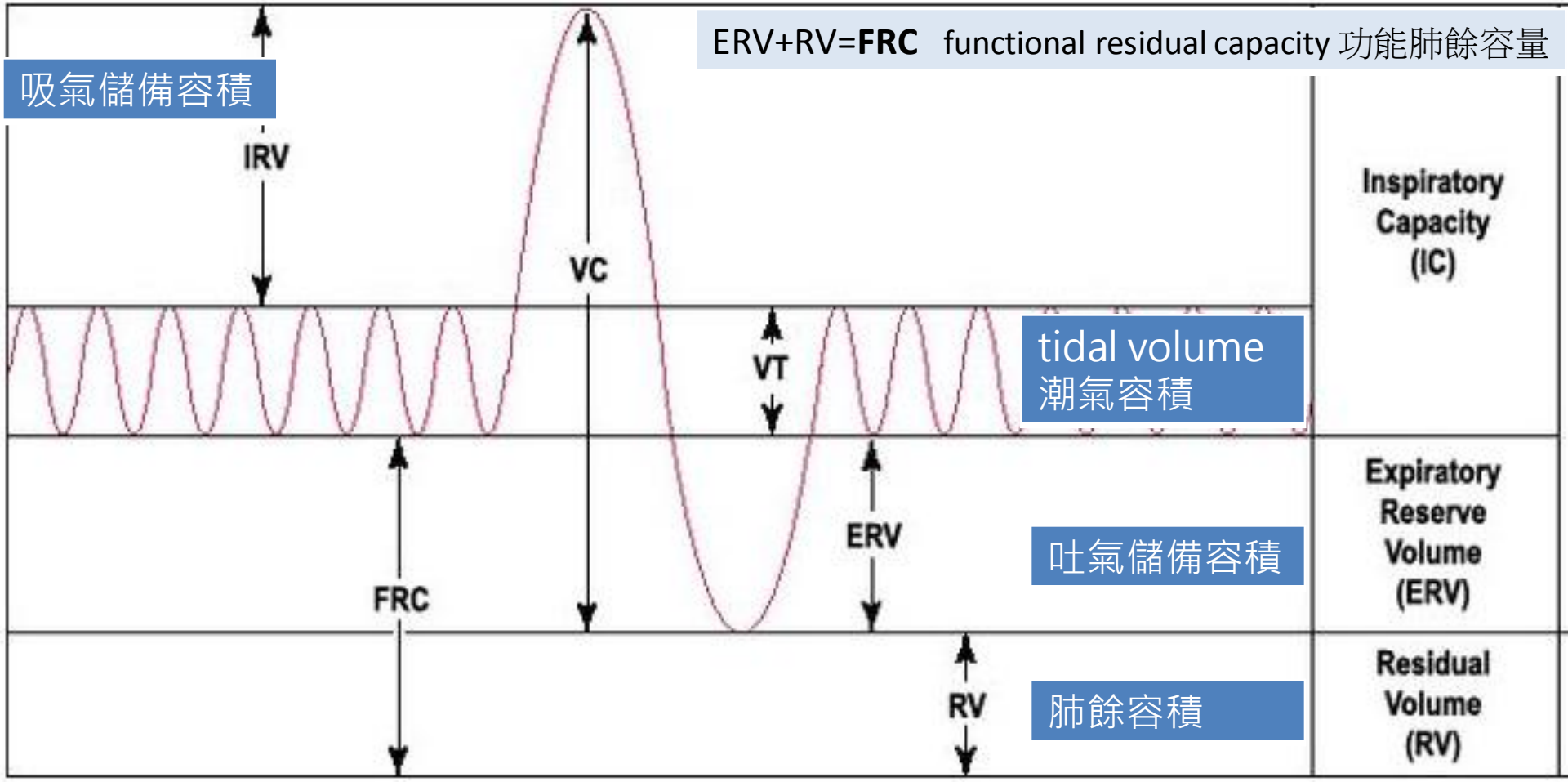
5.檢查結果異常，
□縮短工作時間□更

6.其他(請說明)：

31	銦及其化合物(Indium & its compounds)作業	(1)作業經歷、生活習慣及自覺症狀之調查。 (2)呼吸系統既往病史之調查。 (3)呼吸系統及皮膚黏膜（含眼睛結膜）之身體檢查。 (4)胸部X光（大片）攝影檢查。 (5)肺功能檢查（包括用力肺活量(FVC)、一秒最大呼氣量($FEV_{1.0}$)及$FEV_{1.0}$/ FVC)。	(1)作業經歷、生活習慣及自覺症狀之調查。 (2)呼吸系統既往病史之調查。 (3)呼吸系統及皮膚黏膜（含眼睛結膜）之身體檢查。 (4)胸部X光（大片）攝影檢查。 (5)肺功能檢查（包括用力肺活量(FVC)、一秒最大呼氣量($FEV_{1.0}$)及$FEV_{1.0}$/ FVC)。 (6)血清銦檢查(變更作業者無須檢測)。

ys591@ms2.hinet.net

IRV	吸氣儲備容積	inspiratory reserve volume	3100 ml	肺活量 (vital capacity, FVC) **4800 ml**	肺總容量 (total lung capacity, TLC) 6000 ml
TV	潮氣容積	tidal volume	500 ml		
ERV	吐氣儲備容積	expiratory reserve volume	1200 ml		
RV	肺餘容積	residual volume	1200 ml	肺餘容積	

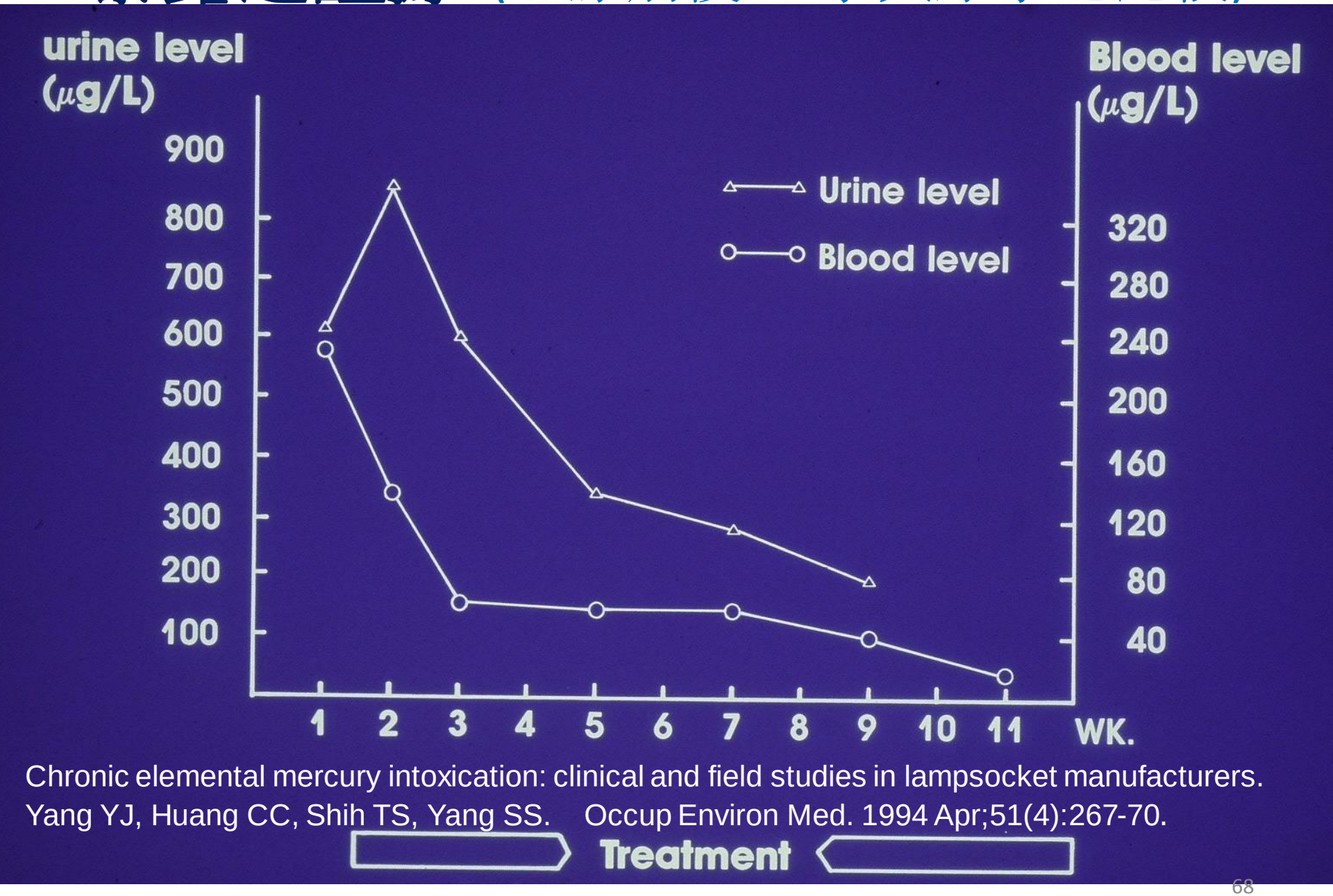


(編號27) (編號32) 汞及其無機化合物作業管理分級

管理分級定義	健康檢查結果管理分級建議
第一級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，全部項目正常，或部分項目異常，而經醫師綜合判定為無異常者。	1. 檢查結果符合下列條件之一： 1.1 法定健康檢查項目無異常發現，或異常結果於追蹤時恢復正常。 1.2 法定健康檢查項目有異常發現，經醫師認定不需於下年度相同特殊健康檢查類別實施前接受健康追蹤檢查。
第二級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，而與工作無關者。	1. 法定健康檢查項目有異常發現，經醫師認定需於下年度相同特殊健康檢查類別實施前接受健康追蹤檢查。 2. 異常項目可由工作以外的原因解釋，如肝功能異常可由病毒性肝炎、脂肪肝、藥物之服用或飲酒習慣等非職業性因素解釋；或泌尿道感染造成之血尿或蛋白尿；肺部感染或其它病因造成之肺纖維化；聽力視力或視野異常可由非職業性因素解釋等。
第三級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，而無法確定此異常與工作之相關性，應進一步請職業醫學科專科醫師評估者。	1. 法定健康檢查或健康追蹤檢查項目有異常發現，且異常項目符合汞及其無機化合物作業的健康危害表現，經醫師綜合判定需請職醫科醫師評估與工作之相關性。 2. 異常結果符合下列條件之一： 2.1 有皮膚暴露部位之皮膚炎、口內炎、神經精神異常、蛋白尿(2價以上(≥100 mg/dL))、聽力視力或視野異常、明顯體重減輕等符合汞及其無機化合物作業之健康危害表現。 2.2 尿中汞濃度≥ 35 μg/g creatinine (上班前)或35 μg/g creatinine(下班時)。 2.3 異常結果無法由工作以外的原因解釋，或事業單位未提供足以判定之作業環境測定記錄。
第四級管理 特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，且與工作有關者。	1. 法定健康檢查或健康追蹤檢查項目有異常發現，且異常項目符合汞及其無機化合物作業的健康危害表現。 2. 異常結果符合下列條件之一： 2.1 有皮膚暴露部位之皮膚炎、口內炎、神經精神異常、蛋白尿(2價以上(≥100 mg/dL))、聽力視力或視野異常、明顯體重減輕等符合汞中毒之臨床表現。 2.2 尿中汞濃度≥ 35 μg/g creatinine (上班前)或35 μg/g creatinine(下班時)。 3. 異常結果可由工作相關原因解釋。

尿汞	**≥ 35 ug/ g Cr** (上班前)
	35 ug/ g Cr (下班時)

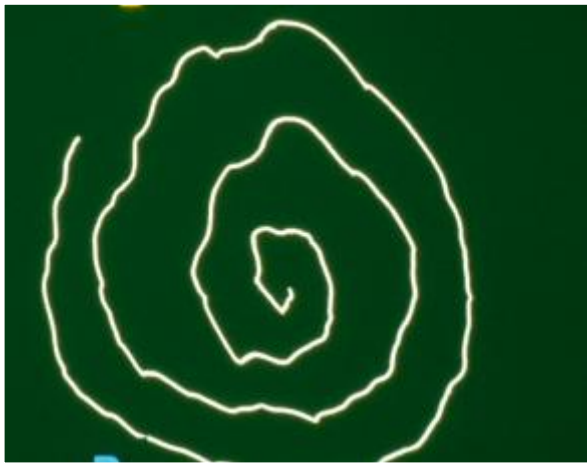
暴露之證據 (治療前後 血汞與尿汞之比較)



Chronic elemental mercury intoxication: clinical and field studies in lampsocket manufacturers. Yang YJ, Huang CC, Shih TS, Yang SS. Occup Environ Med. 1994 Apr;51(4):267-70.

ys591@ms2.hinet.nnet

A27先生29歲「汞作業健檢」



尿中汞濃度 600 μg/L ，血汞濃度240 μg/L

十、健康管理: □第一級管理 □第二級管理 □第三級管理■第四級管理(臨床診斷: 汞中毒)

十一、「應處理及注意事項」(可複選)

1.檢查結果大致正常，請定期健康檢查。

2.檢查結果部分異常，宜在1M內至 腎臟內科，健康追蹤檢查

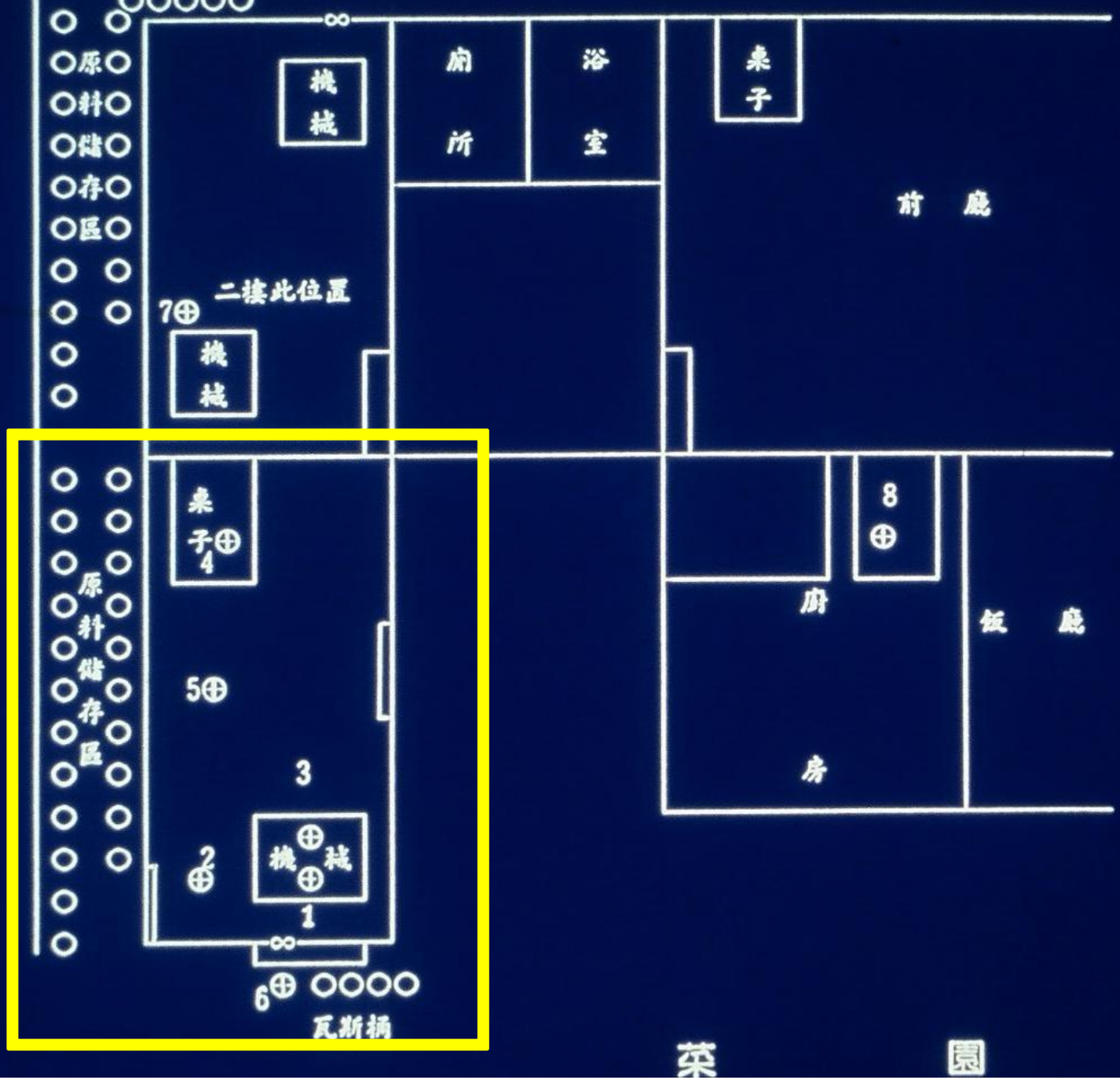
■ 3.檢查結果異常，建議不適宜從事_汞作業(原因: 汞中毒) 。

■ 4.檢查結果異常，應在1M內至聘有職業醫學科專科醫師之門診實施健康追蹤檢查。

■ 5.檢查結果異常，建議調整工作(可複選)：
□縮短工作時間□更換工作內容■變更作業場所(汞中毒)□其他：

■ 6.其他(請說明)：(1).職場訪視/危害辨識與評估 ，(2).環境監測，(3).工作適性評估。

一般及特殊體格(健康)檢查記錄格式 https://www.osha.gov.tw/1106/29647/1141/13440/

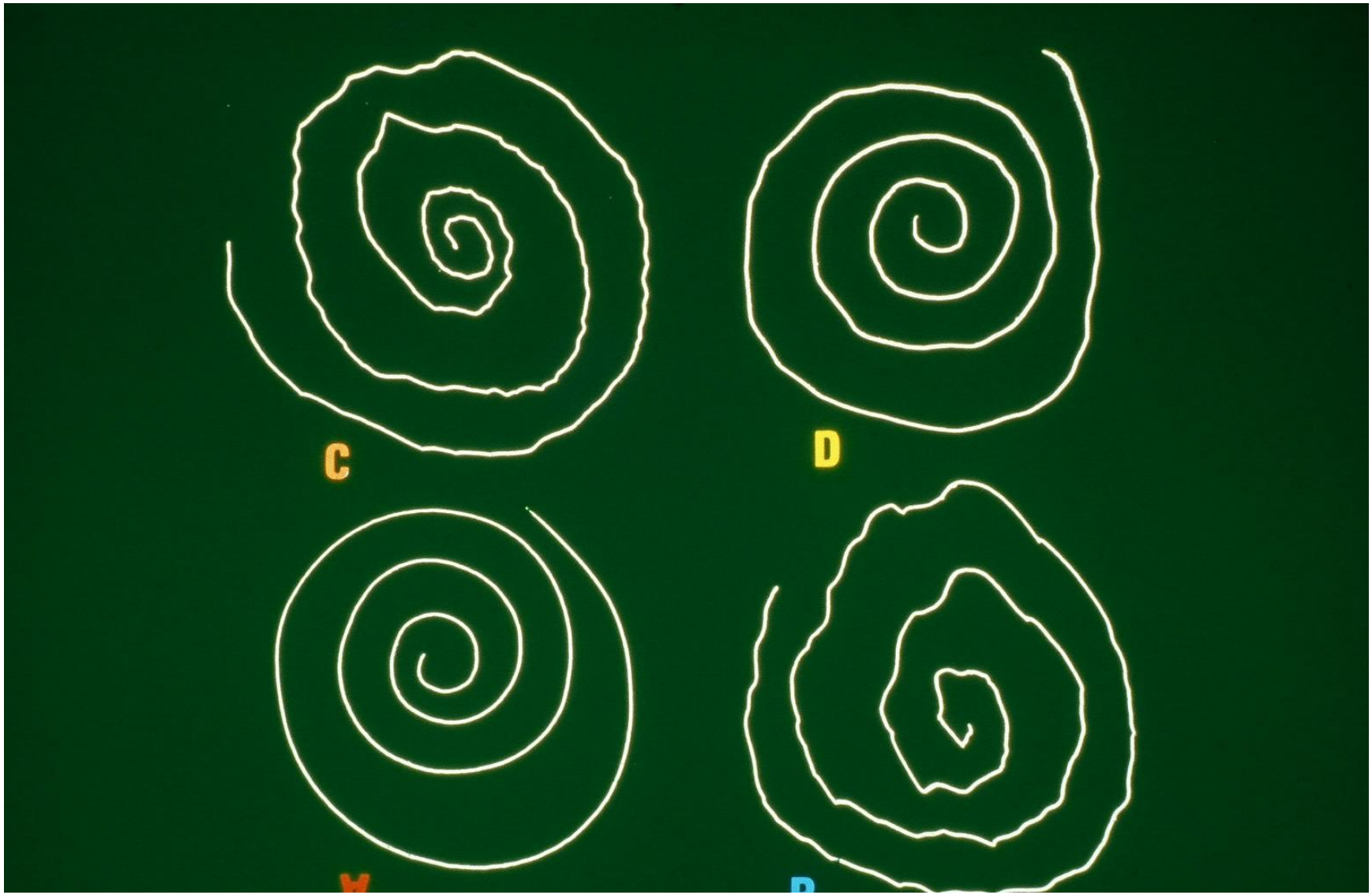


桌子

機器

ys591@ms2.hinet.nnet

後續處理 (治療前後之顫抖程度比較)



Chronic elemental mercury intoxication: clinical and field studies in lampsocket manufacturers.
Yang YJ, Huang CC, Shih TS, Yang SS. Occup Environ Med. 1994 Apr;51(4):267-70.

27	乙基汞化合物	(特殊健檢) 血中汞
32	汞及其無機化合物	(特殊健檢) 尿中汞

27	乙基汞化合物(Ethyl mercury compounds)作業	(1)作業經歷、生活習慣及自覺症狀之調查。 (2)酗酒、精神、神經、肝臟及腎臟疾病等既往病史之調查。 (3)口腔鼻腔、皮膚、呼吸系統、腸胃、腎臟、眼睛、神經系統及精神之身體檢查。 (4)胸部X光(大片)攝影檢查。 (5)尿蛋白、尿潛血及尿沉渣鏡檢之檢查。 (6)肌酸酐(creatinine)之檢查。 (7)血球比容值、血色素、紅血球數及白血球數之檢查。	(1)作業經歷、生活習慣及自覺症狀之調查。 (2)酗酒、精神、神經、肝臟及腎臟疾病等既往病 (3 (4 (5 (6 (7 檢查。 (8)血中汞檢查(變更作業者無須檢測)。
32	汞及其無機化合物(Mercury & its compounds)作業	(1)作業經歷、生活習慣及自覺症狀之調查。 (2)酗酒、精神、神經、肝臟及腎臟疾病等既往病史之調查。 (3)口腔鼻腔、皮膚、呼吸系統、腸胃、腎臟、眼睛、神經系統及精神之身體檢查。 (4)胸部X光(大片)攝影檢查。 (5)尿蛋白、尿潛血及尿沉渣鏡檢之檢查。 reatinine)之檢 值、血色素、 紅血球數及白血球數之檢查。	(1)作業經歷、生活習慣及自覺症狀之調查。 (2)酗酒、精神、神經、肝臟及腎臟疾病等既往病史之調查。 (3)口腔鼻腔、皮膚、呼吸系統、腸胃、腎臟、眼睛、神經系統及精神之身體檢查。 (4)胸部X光(大片)攝影檢查。 (5)尿蛋白、尿潛血及尿沉渣鏡檢之檢查。 (6)肌酸酐(creatinine)之檢查。 (7)血球比容值、血色素、紅血球數及白血球數之檢查。 (8)尿中汞檢查(變更作業者無須檢測)。

ys591@ms2.hinet.net

27 乙基汞化合物 (特殊健檢) 血中汞

3. 胸部 X 光：_____
4. 血液檢查：紅血球數_____ 血色素 血球比容值_____ 白血球數_____
5. 生化血液檢查：肌酸酐(creatinine)_____
6. 尿液檢查：尿蛋白 尿潛血 尿沉渣鏡檢(細胞學檢查)
7. 血中汞檢查：_____

32 汞及其無機化合物 (特殊健檢) 尿中汞

3. 胸部 X 光：_____
4. 血液檢查：紅血球數_____ 血色素_____ 血球比容值_____ 白血球數_____
5. 生化血液檢查：肌酸酐(creatinine)_____
6. 尿液檢查：尿蛋白_____ 尿潛血_____ 尿沉渣鏡檢(細胞學檢查)_____
7. 尿中汞檢查：_____

ys591@ms2.hinet.net

特別危害健康作業	《勞工健康保護規則》2021.12.22	檢查類別代號
既往歷,物理檢查 皮膚	高溫、游離輻射、二硫化碳、三氯乙烯(四氯乙烯)、二甲基甲醯胺、正己烷、鈹及其化合物、氯乙烯、二異氰酸甲苯(二異氰酸二苯甲烷，二異氰酸異佛爾酮)、砷及其化合物、黃磷、聯吡啶或巴拉刈、粉塵、鉻酸及其鹽類、鎳及其化合物、汞及其化合物 、溴丙烷、1,3-丁二烯、甲醛、銦及其化合物	1,3,9,10,11,12,14,15,17,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32
呼吸系統	高溫、游離輻射、氯乙烯、二異氰酸甲苯(二異氰酸二苯甲烷二異氰酸異佛爾酮)、砷及其化合物、錳及其化合物、粉塵、鉻酸及其鹽類、鎳及其化合物、汞及其化合物 、甲醛、銦	1,3,15,17,19,20,23,24,26,27,30,31,32
神經系統	高溫、游離輻射、鉛、四烷基鉛、四氯乙烷、二硫化碳、三氯乙烯(四氯乙烯)、砷及其化合物、錳及其化合物、鎳及其化合物、乙基汞化合物 、溴丙烷、汞及其無機化合物	1,3,5,6,7,9,10,19,20, 26,27 28,32
精神	乙基汞化合物 、汞及其無機化合物	27,32
心臟血管系統	高溫、游離輻射、四烷基鉛、二硫化碳、三氯乙烯(四氯乙烯)、二甲基甲醯胺	1,3,6,9,10,11
口腔牙齒	鉛、鎘及其化合物	5,25
耳道	噪音、異常氣壓	2,4
鼻腔	鉻酸及其鹽類、鎳及其化合物、乙基汞化合物 、汞及其無機化合物	24, 26,27,32
眼睛	乙基汞化合物 、汞及其無機化合物	27,32
甲狀腺	游離輻射	3

檢查類別代號	健檢	A. 十年心血管風險(+工時,睡時,病史) B. 生物標記, 環境監測
4	抗壓力檢查與耐氧試驗，係為評估勞工能否負荷異常壓力，變更作業者應於從事前接受評估。 (高壓艙 1.8 kg/平方公分 +呼吸純氧三十分鐘) 關節X光檢查為評估長期工作者之病變情形，為**在職勞工檢測項目**，**變更作業者無須檢測**。	
17	胸部X係從事該作業前之肺部評估，**變更作業者**應於從事該**作業前**接受評估。	
26, 27	鎳及其化合物、乙基汞化合物、汞及其無機化合物，對人體尚無**肝臟**危害相關實證，另考量腎功能為影響人體排除金屬之重要因素，因此增列肌酸酐之檢查，並刪除血清ALT及r-GT檢測項目。	
28	暴露於溴丙烷之作業環境，可能導致神經系統病變之風險	
29	長期暴露於1,3-丁二烯之作業環境，可能增加白血病或淋巴癌之風險。	
30	暴露於甲醛之作業環境，可能增加鼻咽癌之風險或導致呼吸系統疾病。	
31	長期暴露於鋦及其化合物作業環境，可能導致肺部損傷	

二異氰酸甲苯(二異氰酸二苯甲烷，二異氰酸異佛爾酮)

如何評估神經系統？

- 「游離輻射、鉛、四氯化碳、二硫化碳、三氯乙烯(四氯乙烯)、正己烷、砷及其化合物、錳及其化合物作業、鎳及其化合物、汞及其化合物、溴丙烷」都可能影響神經系統。
- 神經系統理學檢查，以「雙手快速活動」(RAM)評估是否出現不對稱的神經症狀。
- 手繪「 同心圓」，評估是否出現 手抖。

身體、心理健康檢查項目	特別危害健康作業	檢查類別代號
神經系統	高溫、游離輻射、鉛、四烷基鉛、四氯乙烷、二硫化碳、三氯乙烯（四氯乙烯）、砷及其化合物、錳及其化合物、鎳及其化合物、汞及其化合物	1,3,5,6,7,9,10,19,20,26,27
	溴丙烷	28

神經學(手抖)評估單

姓名	年齡	性別	單位(備註)	編號

【說明：請在下列方框內畫圓圈，從中心點開始，由小而大，線條請勿交疊】

日期	日期

【說明：請在下列欄位書寫阿拉伯數字，從 1 到 10】

【說明：請在下列兩條直線之間畫五條平行的橫線】

神經學(手抖)評估單

姓名	年齡	性別	單位(備註)	編號

【說明：請在下列方框內畫圓圈，從中心點開始，由小而大，線條請勿交疊】

日期 2015. 3. 10



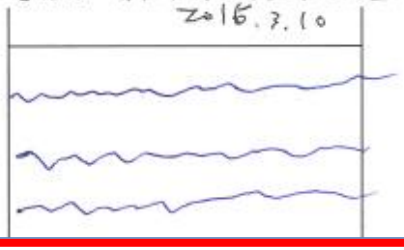
日期 2015. 6. 29

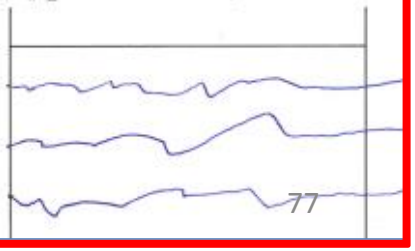


【說明：請在下列欄位書寫阿拉伯數字，從 1 到 10】

【說明：請在下列兩條直線之間畫五條平行的橫線】 2015. 6. 29

2016. 3. 10





特別危害健康作業 《勞工健康保護規則》2021.12.22			類別代號
特殊檢查	尿液(尿蛋白,尿潛血)(尿沉渣鏡檢)	高溫、游離輻射、鉛、四烷基鉛、四氯乙烷、四氯化碳、二硫化碳、三氯乙烯(四氯乙烯)、聯苯胺及其鹽類等、砷及其化合物、鎘及其化合物、鎳及其化合物、汞及其化合物	1,3,5,6,7,8,9,10,13,19,25,26,27
	腎功能(Cr)	高溫、游離輻射、鎳及其化合物、汞及其化合物	1,3,26,27
	肝功能(GPT ,GGT)	游離輻射、四氯乙烷、四氯化碳、二硫化碳、三氯乙烯(四氯乙烯)、二甲基甲醯胺、氯乙烯、砷及其化合物、黃磷、溴丙烷	3,7,8,9,10,11,15,19, 21,28
	血液(CBC)(+ DC)	高溫、游離輻射、鉛、**苯**、砷及其化合物、黃磷、鎳及化合物、汞及化合物、溴丙烷、1,3-丁二烯、**甲醛**	1,3,5,**16**,19,21,26,27,28,29,**30**
	血糖,電解質	高溫	1
	甲狀腺功能	游離輻射	3
	胸部X光	游離輻射、異常氣壓、鈹及其化合物、氯乙烯、石綿、砷及其化合物、錳及其化合物、粉塵、(鉻酸及其鹽類)鎳及其化合物、汞及其化合物、溴丙烷、甲醛、銦及其化合物 +(體格檢查)二異氰酸甲苯(二異氰酸二苯甲烷，二異氰酸異佛爾酮)	3,4,14,15,18,19,20,23,24,26,27,28,30,31 ,32+17
	肺功能	高溫、游離輻射、異常氣壓、鈹及其化合物、二異氰酸甲苯(二異氰酸二苯甲烷，二異氰酸異佛爾酮)、石綿鎘及其化合物、鎳及其化合物、甲醛、銦及其化合物	1,3,4,14,17,18,25,26,30,31
	心電圖	高溫、二硫化碳	1,9

哪一種作業需要測 血中濃度,尿中濃度？

5	血中鉛	鉛 (體格檢查&變更作業者均需測)
6	尿中鉛**	四烷基鉛 (**體格檢查&變更作業者不需測)
19	尿中無機砷**	砷及其化合物 (**體格檢查&變更作業者不需測)
24	**尿中鉻****	**鉻酸及其鹽類** (**體格檢查&變更作業者不需測)
25	尿中鎘**	鎘及其化合物 (**體格檢查&變更作業者不需測)
26	尿中鎳**	鎳及其化合物 (**體格檢查&變更作業者不需測)
27,	血中汞**	乙基汞及其化合物 (**體格檢查&變更作業者不需測)
32	尿中汞**	汞及其無機化合物 (**體格檢查&變更作業者不需測)
31	**血清鋇****	**鋇及其化合物** (**體格檢查&變更作業者不需測)
13	尿細胞診斷檢查	聯苯胺及其鹽類等
4	長骨關節部X光**	異常氣壓 (關節有問題者) (**體格檢查&變更作業者不需測)
	抗壓力檢查,耐氧試驗	異常氣壓 (體格檢查&變更作業者須側)
16	白血球分類**	苯 (**體格檢查&變更作業者無須檢測白血球分類之檢查)。
24	胸部X光	鉻酸及其鹽類 (限從事工作4年以上)
17	胸部X光	**甲醛**, TDI,MDI, IPDI,(二異氰酸甲苯,二異氰酸二苯甲烷,二異氰酸異佛爾酮) (體格檢查&變更作業者均需測)

勞工健康保護規則 2021.12.22

特殊體格檢查	特殊健康檢查
僱用	定期/ 變更作業

第二十一條　雇主使勞工從事第二條規定之特別危害健康作業時，應建立其暴露評估及健康管理資料，並將其定期實施之特殊健康檢查，依下列規定分級實施健康管理。

管理（第一級）			
第二級	註明不適宜從事之作業與其他應處理及注意事項	個人健康指導	
第三級		註明臨床診斷	職醫:1.健康追蹤檢查，2.工作相關疾病現場評估，3.重新分級，通報分級結果及採行措施
第四級			採取危害控制及相關管理措施

勞工健康檢查	
分級	健康管理
2	健康指導
3	現場評估
4	危害控制

前項所定健康管理，屬於第二級管理以上者，應由醫師註明其不適宜從事之作業與其他應處理及注意事項；屬於第三級管理或第四級管理者，並應由醫師註明臨床診斷。

雇主對於第一項所定第二級管理者，應提供勞工個人健康指導；第三級管理者，應請職業醫學科專科醫師實施健康追蹤檢查，必要時應實施疑似工作相關疾病之現場評估，且應依評估結果重新分級，並將分級結果及採行措施依中央主管機關公告之方式通報；屬於第四級管理者，經職業醫學科專科醫師評估現場仍有工作危害因子之暴露者，應採取危害控制及相關管理措施。

前項健康追蹤檢查紀錄，依前二條規定辦理

ys591@ms2.hinet.net

勞工健康保護規則 2021.12.22

第二十三條　雇主於勞工經體格檢查、健康檢查或健康追蹤檢查後，應採取下列措施：

一、參採醫師依附表十二規定之建議，告知勞工，並適當配置勞工於工作場所作業。

二、對檢查結果異常之勞工，應由醫護人員提供其健康指導；其經醫師健康評估結果，不能適應原有工作者，應參採醫師之建議，變更其作業場所、更換工作或縮短工作時間，並採取健康管理措施。

三、將檢查結果發給受檢勞工。

四、彙整受檢勞工之歷年健康檢查紀錄。

前項第二款規定之健康指導及評估建議，應由第三條、第四條或第十三條規定之醫護人員為之。但依規定免僱用或特約醫護人員者，得由辦理勞工體格及健康檢查之醫護人員為之。

第一項規定之勞工體格及健康檢查紀錄、健康指導與評估等勞工醫療資料之保存及管理，應保障勞工隱私權。

第二十四條　雇主使勞工從事本法第十九條規定之高溫度、異常氣壓、高架、精密或重體力勞動作業時，應參採從事勞工健康服務醫師綜合評估勞工之體格或健康檢查結果之建議，適當配置勞工之工作及休息時間。

前項醫師之評估，依第三條或第四條規定免僱用或特約醫師者，得由辦理勞工體格及健康檢查之醫師為之。

勞工健康檢查
1　縮短工作時間
2　變更作業場所
3　更換工作

作業
高溫度
異常氣壓
高架
精密
重體力

ys591@ms2.hinet.net

法規	選工 + 配工 + 復工
職業安全衛生法.第 21 條	雇主依前條體格檢查發現應僱勞工**不適於從事某種工作，不得僱用其從事 該項工作..**
	醫師評估:**不能適應原有工作者**，應參採建議，變更作業場所、更換工作或縮短工作時間..
勞工健康保護規則.第 **23** 條	參採醫師依附表12建議，適當配置工作場所作業(變更作業場所、更換工作或縮短工作時間)
勞工健康保護規則.第 **24** 條	高溫、異常氣壓、高架、精密或重體力勞動作業，應參醫師建議，適當配置工作及休息時間
勞工職業災害保險及保護法.第 67 條 (2022..5.1)	職業災害勞工經醫療終止後，雇主應..定**復工計畫**，並協助其恢復原工作；無法恢復原工作者，經勞雇雙方協議，應按其健康狀況及能力安置適當之工作。
勞工職業災害保險及保護法 .第84 條	非有下列情形之一者，雇主不得預告終止與職業災害勞工之勞動契約：...二、職業災害勞工經醫療終止後，經..醫院評鑑合格醫院認定身心障礙不堪勝任工作。
勞工職業災害保險及保護法.第 88 條	職業災害未認定前，勞工得先請普通傷病假；普通傷病假期滿，申請留職停薪者，雇主應予留職停薪。經認定結果為職業災害者，再以公傷病假處理。

選工相關法規:《勞工健康保護規則》2021.12.22 (附表12)

附表12　選配工時 **宜考量疾病**之建議表

作業名稱	考量之疾病
高溫作業	高血壓、心臟病、呼吸系統疾病、內分泌系統疾病、無汗症、腎臟疾病、廣泛性皮膚疾病。
低溫作業	高血壓、風濕症、支氣管炎、腎臟疾病、心臟病、周邊循環系統疾病、寒冷性蕁麻疹、寒冷血色素尿症、內分泌系統疾病、神經肌肉系統疾病、膠原性疾病。
噪音作業	心血管疾病、聽力異常。
振動作業	周邊神經系統疾病、周邊循環系統疾病、骨骼肌肉系統疾病。
精密作業	矯正後視力零點八以下或其他嚴重之眼睛疾病。
游離輻射作業	血液疾病、內分泌疾病、精神與神經異常、眼睛疾病、惡性腫瘤。
非游離輻射作業	眼睛疾病、內分泌系統疾病。
異常氣壓作業	呼吸系統疾病、高血壓、心血管疾病、精神或神經系統疾病、耳鼻科疾病、過敏性疾病、內分泌系統疾病、肥胖症、疝氣、骨骼肌肉系統疾病、貧血、眼睛疾病、消化道疾病。
高架作業	癲癇、精神或神經系統疾病、高血壓、心血管疾病、貧血、平衡機能失常、呼吸系統疾病、色盲、視力不良、聽力障礙、肢體殘障。
鉛作業	神經系統疾病、貧血等血液疾病、腎臟疾病、消化系統疾病、肝病、內分泌系統疾病、視網膜病變、酒精中毒、高血壓。
四烷基鉛作業	精神或神經系統疾病、酒精中毒、腎臟疾病、肝病、內分泌系統疾病、心臟疾病、貧血等血液疾病、接觸性皮膚疾病。

ys591@ms2.hinet.net

("考量不適合"從事之疾病，但並非絕對。 主要看症狀.....)

選工相關法規:《勞工健康保護規則》2021.12.22 (附表12)

附表12　選配工時 **宜考量疾病**之建議表

粉塵作業	心血管疾病、慢性肺阻塞性疾病、慢性氣管炎、氣喘等。
四氯乙烷作業	神經系統疾病、肝臟疾病等。
三氯乙烯、四氯乙烯作業	慢性肝炎患者、酒精性肝炎、腎臟疾病、心血管疾病、神經系統疾病、接觸性皮膚疾病等。
二甲基甲醯胺作業	慢性肝炎患者、酒精性肝炎、腎臟疾病、心血管疾病、神經系統疾病、接觸性皮膚疾病等。
正己烷作業	周邊神經系統疾病、接觸性皮膚疾病等。
4-胺基聯苯及其鹽類、4-硝基聯苯及其鹽類、α-萘胺及其鹽類之作業	膀胱疾病
3, 3'-二氯聯苯胺及其鹽類之作業	腎臟及泌尿系統疾病、接觸性皮膚疾病。
聯苯胺及其鹽類與β萘胺及其鹽類之作業	腎臟及泌尿系統疾病、肝病、接觸性皮膚疾病。
鈹及其化合物作業	心血管疾病、慢性肺阻塞性疾病、慢性氣管炎、氣喘、接觸性皮膚疾病、慢性肝炎、酒精性肝炎、腎臟疾病等。
氯乙烯作業	慢性肝炎患者、酒精性肝炎、腎臟疾病、心血管疾病、神經系統疾病、接觸性皮膚疾病等。
二異氰酸甲苯、二異氰酸二苯甲烷、二異氰酸	心血管疾病、慢性肺阻塞性疾病、慢性氣管炎、氣喘等。

選工相關法規:《勞工健康保護規則》2021.12.22 (附表12)

附表12　選配工時 **宜考量疾病**之建議表

汞及其無機化合物、有機汞之作業	精神或神經系統疾病、內分泌系統疾病、腎臟疾病、肝病、消化系統疾病、動脈硬化、視網膜病變、接觸性皮膚疾病。
重體力勞動作業	呼吸系統疾病、高血壓、心血管疾病、貧血、肝病、腎臟疾病、精神或神經系統疾病、骨骼肌肉系統疾病、內分泌系統疾病、視網膜玻璃體疾病、肢體殘障。
醇及酮作業	肝病、神經系統疾病、視網膜病變、酒精中毒、腎臟疾病、接觸性皮膚疾病。
苯及苯之衍生物之作業	血液疾病、肝病、神經系統疾病、接觸性皮膚疾病。
石綿作業	心血管疾病、慢性肺阻塞性疾病、慢性氣管炎、氣喘等。
二硫化碳之作業	精神或神經系統疾病、內分泌系統疾病、腎臟疾病、肝病、心血管疾病、視網膜病變、嗅覺障礙、接觸性皮膚疾病。
脂肪族鹵化碳氫化合物之作業	神經系統疾病、肝病、腎臟疾病、糖尿病、酒精中毒、接觸性皮膚疾病。
氯氣、氟化氫、硝酸、硫酸、鹽酸及二氧化硫等刺激性氣體之作業	呼吸系統疾病、慢性角膜或結膜炎、肝病、接觸性皮膚疾病、電解質不平衡。
鉻酸及其鹽類、重鉻酸及其鹽類之作業	呼吸系統疾病、接觸性皮膚疾病。
砷及其化合物之作業	精神或神經系統疾病、貧血、肝病、呼吸系統疾病、心血管疾病、接觸性皮膚疾病。

ys591@ms2.hinet.net

選工相關法規:《勞工健康保護規則》2021.12.22 (附表12)

附表12　選配工時 **宜考量疾病**之建議表

硝基乙二醇之作業	心血管疾病、低血壓、精神或神經系統疾病、貧血等血液疾病、接觸性皮膚疾病。
五氯化酚及其鈉鹽之作業	低血壓、肝病、糖尿病、消化性潰瘍、精神或神經系統疾病、接觸性皮膚疾病。
錳及其化合物之作業	精神（精神官能症）或中樞神經系統疾病(如巴金森症候群)、慢性呼吸道疾病、精神疾病、肝病、腎臟疾病、接觸性皮膚疾病。
硫化氫之作業	角膜或結膜炎、精神或中樞神經系統疾病、嗅覺障礙。
苯之硝基醯胺之作業	貧血等血液疾病、肝病、接觸性皮膚疾病、神經系統疾病。
黃磷及磷化合物之作業	牙齒支持組織疾病、肝病、接觸性皮膚疾病。
有機磷之作業	精神或神經系統疾病、肝病、接觸性皮膚疾病。
非有機磷農藥之作業	呼吸系統疾病、肝病、精神或神經系統疾病、接觸性皮膚疾病。
聯吡啶或巴拉刈作業	皮膚疾病如：接觸性皮膚炎、皮膚角化、黑斑或疑似皮膚癌病變等。
鎳及其化合物之作業	呼吸系統疾病、皮膚炎
1,3-丁二烯之作業	血液疾病
甲醛之作業	鼻炎、慢性氣管炎、肺氣腫、氣喘等
鈷及其化合物之作業	肺部疾病
溴丙烷之作業	神經系統疾病、皮膚炎

備註：

1. 本表所使用之醫學名詞，精神或神經系統疾病包含癲癇，內分泌系統疾病包含糖尿病。

ys591@ms2.hinet.net

【附錄六】　特殊作業健康管理之績效指標

執行項目	執行結果（人次或%）	備註（改善情形）
健康檢查項目分級管理結果(粉塵、噪音、正己烷、鎳作業)	**粉塵作業** 第一級管理人數__73___人(_____%) 第二級管理人數___10__人(_____%) 第三級管理人數___0___人(_____%) 第四級管理人數___0___人(_____%) **正己烷作業** 第一級管理人數___7___人(_____%) 第二級管理人數___0___人(_____%) 第三級管理人數___0___人(_____%) 第四級管理人數___0___人(_____%) **噪音作業** 第一級管理人數___35__人(_____%) 第二級管理人數___13__人(_____%) 第三級管理人數___0___人(_____%) 第四級管理人數___0___人(_____%) **鎳作業** 第一級管理人數___70___人(_____%) 第二級管理人數___45___人(_____%) 第三級管理人數___0____人(_____%) 第四級管理人數___0____人(_____%) (依特殊健檢類別分別列出) (可另列明重新分級的管理人數及百分比)	詳見紀錄 2021.11.23 及 2021.12.27 (依據「特殊作業健康管理計畫」，提供個人健康指導，與健康管理。

ys591@ms2.hinet.net

辨識及評估健康檢查異常者(噪音作業)	噪音作業 第三級者重新分級為第二級者__1___人 第三級者重新分級為第四級者__0___人 (健檢報告異常且可能有考量不適合疾病者_0__人)	
安排護理師面談及健康指導(粉塵、噪音、正己烷、錳作業)	粉塵作業 1.需護理師面談者__10___人 1.1 需觀察或進一步追蹤檢查者_0__人 1.2 需進行醫療者 _0__人 2.需健康指導者_10__人 2.1 已接受健康指導者 _10__人 噪音作業 1.需護理師面談者__13___人 1.1 需觀察或進一步追蹤檢查者_0_人 1.2 需進行醫療者 _0__人 2.需健康指導者_0__人 2.1 已接受健康指導者 _0__人 正己烷作業 1.需護理師面談者__0___人 1.1 需觀察或進一步追蹤檢查者_0__ 人 1.2 需進行醫療者 _0__人 2.需健康指導者_0__人 2.1 已接受健康指導者 _0__人	

ys591@ms2.hinet.net

	2.經安排，實際完成適性配工者 0 人 2.1 實際調整或縮短工作時間 0 人 2.2 實際變更工作者 0 人 2.3. 實際調整工作內容者 0 人	
實施健康檢查、管理及促進	1.應實施健康檢查者 260 人 1.1 實際受檢者 254 人 1.2 檢查結果異常者 69 人 1.3 需複檢者 1 人	
	2.應定期追蹤管理者 69 人 3.參加健康促進活動者 69 人	
執行成效之評估及改善	1.參與健康檢查率 100 % 2.健康促進達成率 100 % 3.與上一次健康檢查異常結果項目比較，異檢率 % （上升或下降） 4.環境改善情形： (環測結果）	
其他事項		

註：本表執行結果為例舉，事業單位得依需求修正與增列。

可將上述結果，定期檢討、改善及持續修正，並於職業安全衛生委員會報告，做為下一年度規劃勞工健康服務業務的參考。